

Разное

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА УХОДА ЗА ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ

Абдрахманова Л.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: ежегодно в отделении общей онкологии получают специализированную помощь свыше 1000 пациентов. Выполняется более 850 операций. Объем медицинской помощи возрастает с каждым годом, поэтому необходимо улучшить условия пребывания больных в стационаре, уменьшить число осложнений, поднять престиж и профессионализм медицинских сестер. Этому

Цели работы: проанализировать влияние соблюдения принципов этики и деонтологии медицинской сестры хирургического отделения в процессе выздоровления больных.

Материалы и методы: отчет отделения за 2009 год, материалы семинаров по этике и деонтологии, проводимых в отделении.

Функции медицинских сестер значительно шире, чем простое выполнение указаний врача. Это: выполнение медицинскими сестрами своих обязанностей по оказанию помощи пациентам, составление плана действия по уходу, оценка своей работы. Для медицинской сестры онкологического учреждения прежде всего важна культура общения, личные, духовные и эстетические качества, образованность, высокий профессионализм, коммуникабельность, умение вовремя оказать психологическую поддержку, высокая степень нравственного долга перед больным человеком. Все мероприятия по улучшению качества жизни онкологических пациентов основаны на доверии между врачом, медицинской сестрой и пациентом. Они требуют длительного и кропотливого участия медицинской сестры не только в обеспечении необходимой лечебной помощи, но и в процессе организации социальной и психологической поддержки и его реабилитации. Основным методом лечения онкологических больных – хирургический. За 2009г. в отделении общей онкологии было выполнено 850 операций. Из них: 193 на органах пищеварительной системы, 275 на молочных железах, 185 на женских половых органах, на кишечнике 85. Радикальные операции травматичны сами по себе и часто приводят к инвалидности и психосоматическим нарушениям. Существуют также и паллиативные методы лечения. Из проводимых в отделении операций наиболее травматичной считается наложение колостомы больным с заболеваниями толстого отдела кишечника. Таких операций в год проводится в среднем около 30. Многим больным необходима психологическая поддержка до операции, поскольку психология стресса очень сильно влияет на соматическую сферу человека. Медсестре необходимо выявить типологию пациента и адекватно взаимодействовать с ним. За время нахождения в стационаре медсестра должна научить больного правильному уходу за колостомой, помочь в выборе диеты. Пациента могут напугать обильные, нерегулярные выделения с неприятным запахом, раздражение ткани вокруг колостомы. Задачами медицинского персонала являются восстановление жизненно-важных функций организма, обеспечение заживления послеоперационной раны, предупреждение осложнений. Чуткое отношение, внимание со стороны медицинской сестры помогает в процессе выздоровления пациента. Медицинская сестра, выполняя процедуру, может повлиять на пациента своим настроением, взглядом, интонацией. Медсестра может поддержать, утешить, успокоить больного. Иногда это намного важнее, чем сама процедура. Надежная бригада, состоящая из врача, медицинской сестры и самого пациента, должна

быть постоянной опорой в его борьбе с недугом.

Результаты и выводы: онкологические больные требуют от среднего медицинского персонала не только высоких профессиональных навыков, но и особого внимания, чуткости, душевного подхода к его проблемам. Медицинская сестра не должна противоречить информации, которую врач всячески помогать пациенту в адаптации и правильного восприятия заболевания. Знание основ психологии должно быть приоритетом современной медсестры.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДИСПАНСЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Абугалиева Г.С.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность работы: Павлодарская область в течение 3-х последних лет занимает первое ранговое место в РК по уровню онкологической заболеваемости и смертности. Обеспеченность онкологическими койками составляет 2,3 на 10.000 населения (в РК – 2,2 на 10,000 населения). С учетом уровня заболеваемости данное количество коек недостаточно. Предельные объемы госпитализации в рамках Государственного заказа в течение 3-х последних лет составляют 4000 больных в год. В этих условиях особенно важным является оптимизация стационарозамещающей помощи, позволяющей рационально использовать финансовые ресурсы. Специализированную онкологическую помощь населению Павлодарского Прииртышья оказывает областной онкологический диспансер с мощностью стационара – 170 коек, поликлиники на 50 посещений в смену, 12 районных онкологических кабинетов и 33 смотровых кабинетов в городах и районах области.

Цель работы: Изучение состояния стационарозамещающей помощи в ПООД с 2007 по 2009 г.г.

Материалы и методы: Материалом для данной работы явились статистические карты прошедшего лечения в дневном стационаре и стационаре на дому – Ф 066-4/у, счета-реестры.

В Павлодарском областном онкологическом диспансере с 28.05.1999 года приказом ДЗО № 195-пр. организован дневной стационар на 30 коек, из которых 20 радиологических коек и 10 коек при диспансерном отделении, предназначенных, в основном, для проведения амбулаторных оперативных вмешательств, химиотерапии и медицинской реабилитации онкологических больных.

Количество пролеченных больных в дневном стационаре диспансерного отделения и в стационаре дневного пребывания больных при радиологическом отделении за 2007 – 2009 г.

Вид стационара и лечения	2007	2008	2009
Дневной стационар при диспансерном отделении	1223	1287	1468
Стационар дневного пребывания при радиологическом отделении	301	337	398

Динамика финансовых показателей по дневному стационару за 2007 – 2009 г.г.

Показатели	Годы		
	2007	2008	2009

Заработано средств по счетам-реестрам	20860200 т.	22644000 т.	28857400 т.
Тариф за пролеч. больного	11700 т.	12580 т.	14.00 т.

Результаты и выводы: Ежегодно увеличивается общее число больных, получивших стационарозамещающую помощь. Ежегодно увеличивается финансирование стационарозамещающей помощи, увеличиваются средства для проведения специального лечения за счёт применения современных, дорогостоящих, эффективных химиопрепаратов. Эффективно используются современные аппараты для проведения лучевой терапии.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАММОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Альгожин Т.Б.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар

Актуальность: Всевозрастающий интерес к проблемам маммологии вызван ростом заболеваемости раком молочной железы, высокими показателями запоздалой диагностики, смертности и однодневной летальности в наиболее развитых странах.

Цель работы: разработать оптимальный алгоритм оказания маммологической помощи женщинам Павлодарской области.

Материалы и методы: опыт оказания маммологической помощи за 2007 – 2009 годы в области.

В Республике Казахстан ежегодно регистрируется около 3000 женщин с раком молочной железы, в Павлодарской области - более 250. Намечилась тенденция к лидирующему положению РМЖ в структуре онкологической заболеваемости. Этот факт диктует необходимость поиска новых методов ранней диагностики патологии молочной железы, совершенствованию уже существующих, улучшению методов управления лечебно-диагностическим процессом, повышению качества диспансеризации женщин с неонкологической патологией молочной железы, как наиболее вероятного контингента по риску возникновения РМЖ в течение предстоящей жизни.

Основными принципами улучшения качества маммологической помощи являются:

1. Доврачебная помощь: должно быть обеспечена доступность маммологической помощи, максимальная приближенность её к населению. Эта задача обеспечивается акушерками смотровых кабинетов ЛПО ПМСП, фельдшерами. Основными формами работы на этом этапе являются профилактические осмотры женщин, анкетирование женщин с формированием групп повышенного риска и передачи информации на следующий уровень. Обеспечение преемственности в работе должно контролироваться врачом-гинекологом ЦРБ и районкологом. На этом этапе важнейшим компонентом профилактической работы являются подворовые обходы с осмотром неорганизованного населения, особенно старших возрастных групп.

2. Первая врачебная помощь: осуществляется гинекологом, хирургом ЦРБ и городских ЛПО. Всем пациенткам в возрасте после 30 лет, впервые обратившимся в текущем году в лечебно-профилактические учреждения, а также госпитализированным в стационары, в обязательном порядке должны быть осмотрены молочные железы. Женщины с выявленными узловыми образованиями в молочных железах, должны быть направлены на консультацию к маммологу онкодиспансера.

3. Специализированная помощь: оказывается маммологами областного диспансера. Наличие в диспансере маммогра-

фической установки, УЗ аппаратов с большой разрешающей способностью, функционирующие патоморфологическая и цитологическая лаборатории, иммуногистохимическая лаборатория позволят произвести дифференциальный диагноз, назначить лечение фоновых заболеваний и при выявлении рака молочной железы своевременно взять больную на учёт.

4. Высококвалифицированная помощь: оказывается специалистами Казахского НИИ онкологии и радиологии с применением высокотехнологичных эффективных современных методов лечения в соответствии с международными стандартами на основе последних научных разработок.

5. Информационное обеспечение: обеспечивается санитарно-просветительской работой в СМИ. Из нашего опыта эффективным методом пропаганды является проведение декадников, дней открытых дверей, организация широкомасштабных акций.

Результаты и выводы: Улучшение состояния маммологической помощи женскому населению может быть достигнуто применением комплекса организационных, лечебно-профилактических мероприятий на всех этапах медицинской помощи.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Дробкова О.М.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар

Актуальность: залог успешной и слаженной работы всего отделения - это слаженно работающий коллектив, уважительное отношение коллег между друг другом, а также с пациентами, и огромная роль в этом отводится именно медицинским сестрам.

В настоящее время в торакальном отделении ПООД оказывают плановую специализированную медицинскую помощь при заболеваниях легких, пищевода, желудка, опухолях средостения и шеи, заболевания мягких тканей грудной клетки, специфичность нашего отделения еще и в том, что оказывается экстренная помощь при ранениях и травмах грудной клетки и средостения, легочных кровотечениях. Ежегодно в торакальном отделении получают специализированную помощь свыше 900 пациентов. Выполняется более 300 операций.

Цель исследования: проанализировать принципы работы медицинской сестры в условиях хирургического отделения.

Материалы и методы: алгоритмы работы среднего медицинского персонала, протоколы оказания экстренной помощи.

В отделении работают 90% медицинских сестер с первой и высшей категорией. Высокий уровень их квалификации является неотъемлемой частью качественной работы отделения. Выполнение назначений врачей, перевязок, контроль за температурой, артериальным давлением пациентов, контроль за положением дренажей в плевральной и брюшной полостях, а также отделяемых по ним жидкостям, контроль за основными физиологическими показателями и функций жизненно важных органов, проведение комплекса профилактических мероприятий для улучшения дыхательной функции и для предупреждения осложнений, обезболивание пациентов это лишь часть обязанностей которые выполняют медицинские сестры в торакальном отделении. Особенности в работе медицинской сестры в хирургическом отделении заключается в умении работать со сложным медицинским оборудованием, ассистировать врачу при постановке дренажей, санационной и диагностической фибробронхоскопии, проведении гемотрансфузий, умение правильно подготовить больного и собрать анализы. Данные манипуляции требуют высочайшего уровня подготовки среднего медицинского персонала работающего в торакальном отделении. Одним

из важнейших качеств медицинской сестры любого уровня является сострадание пациенту, ответственный и профессиональный подход к своей работе. Для улучшения качества лечения необходимо внимательное и чуткое отношение к проблемам больного, что особенно актуально в условиях единой системы здравоохранения. Необходимо постоянно повышать специальные знания медицинских сестер. Это достигается путем проведения регулярных семинаров для среднего персонала отделения по вопросам этики и деонтологии, техники процедур, специальным навыкам и знаниям по смежным специальностям. На базе Павлодарского медицинского колледжа проводится постдипломное обучение по терапевтическому и хирургическому профилю. Немало важную роль играют ежегодное проведение конкурсов на лучшую медицинскую сестру, проводимые в условиях диспансера и участие победителей в областных олимпиадах. В недалеком будущем квалификация медицинского работника, его профессионализм будут напрямую влиять на его уровень заработной платы. Приказ МЗ РК № 249 от 12.04.2010г. «Об утверждении правил оплаты труда медицинских работников» предусматривает возможность стимулирующей доплаты к заработной плате медицинских работников. Поскольку сестринское дело является центральной частью индустрии охраны здоровья, в настоящее время резко изменяется отношение общества к медицинским сестрам, престиж нашей профессии растет.

Результаты и выводы: Выполнение сложнейших операций дает пациенту 50% шансов на благополучный исход, остальные 50% зависят от послеоперационного ухода, большая часть которого ложится на плечи медицинской сестры.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РЕТИНОБЛАСТОМЕ

Исламов З.С.

Республиканский онкологический научный центр,
Узбекистан, Ташкент.

Ретинобластома злокачественная внутриглазная опухоль, развивающаяся из сетчатки, встречается в основном у детей дошкольного возраста. Как отмечает Бровкина А.Ф. (2002), в последнее время она имеет тенденция к взрослению, то есть у детей более старшего возраста. Опухоль, на разных стадиях маскируется под многие заболевания глаза у детей.

Целью нашей работы явился анализ больных с ретинобластомой поступивших на стационарное лечение в онкоофтальмологическое отделение.

Материал и методы. Нами анализированы истории болезни и амбулаторные карточки 355 детей госпитализированных в онкоофтальмологическое отделение РОНЦ МЗ РУз с 2001 по 2010 гг. на стационарное обследование и лечение с диагнозом ретинобластома. Все больные обследованы: методом бокового освещения, офтальмоскопии, биомикроскопии, УЗИ и Допплерографии, КТ.

Результаты. В результате обследования из 355 больных у 44 диагноз ретинобластома не подтвердился. Им установлены следующие диагнозы и направлены детским офтальмологам: Ретинит Коатса, Ретрогенальная фиброплазия, Фиброз стекловидного тела, Увеит, Эндофтальмит, Хориоретинальная дегенерация сетчатки, Отслойка сетчатки, Колобома сосудистой оболочки, Вторичная глаукома.

Из 311 больных с ретинобластомой 53,8% составляли мальчики и 46,2% девочки. Возраст больных колебался от 1 месяца до 11 лет. Больных до 1 года было 19,7%, от 1 до 3 лет — 60%. Основная масса больных - 94,1% обратившихся к нам с диагнозом ретинобластома были в возрасте до 6 лет. После 6 лет до 11 лет количество больных резко уменьшается (5,8%). Больных с односторонней ретинобластомой было 77,4%, двусторонней 22,5%. У 17,5% была обнаружена ретинобластома в стадии T1N0M0. В 51% была

диагностирована стадия T2N0M0. В 20,4% случаях обнаружена стадия T3 и в 9% случаях была стадия T4. Опухоль в стадии T1 в основном была выявлена в парных глазах у больных с двусторонней ретинобластомой (60 глаз), только у 2 больных стадия T1 была выявлена в одностороннем процессе первично.

Время прошедшее, когда родители заметили первые признаки ретинобластомы до начала обследования и адекватного лечения, варьировала от 1 недели до 5 лет. У 4 больных (1,4%) признаки ретинобластомы - свечение зрачка заметили сразу после рождения, но обратились к онкоофтальмологу через 2, 6, 9 и 10 месяцев, соответственно. Лишь только в трёх случаях (1%) больных привели к онкоофтальмологу через неделю после проявления первых симптомов болезни. У 138 больных (48%) от обнаружения симптомов до поступления в стационар прошло от 1 до 6 месяцев. У 108 больных (37%) до поступления в стационар ушло 6 месяцев и более. У 30 больных (10,4%) от начала заболевания до поступления в стационар прошел 1 год и более. У 3 больных (1%) до обращения к онкоофтальмологу прошло 3 года, у одного больного (0,3%) от появления первых симптомов до получения адекватного лечения прошло 5 лет. Большинство больных обратившихся с запущенными формами были развитых стадиях опухолевого процесса, и в возрасте 5 лет и старше. В этих стадиях клиническая картина ретинобластомы может быть разнообразной, похожей на другие заболевания глаза, с их симптоматикой. Всё это время эти больные получали неадекватное лечение от других болезней, или же просто не обращались к врачам, и лечились у знахарей.

Выводы. Возникновение ретинобластомы у детей более старшего возраста, с клинической картиной других заболеваний глаза и отсутствие онкологической настороженности могут привести к диагностическим ошибкам и запущенным случаям.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В РАДИОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

Каримова Г.А.

КГКП «Областной онкологический диспансер», г.
Павлодар

Актуальность работы: В лечении больных злокачественными опухолями нельзя ограничиваться только облучением опухоли. Необходимо мобилизовать все средства для лечения самого больного, используя при этом современный арсенал лечебных мероприятий. Важным критерием эффективности лучевой терапии является также предупреждение развития лучевых реакций и повреждений здоровых тканей. В ведении больных, получающих лучевую терапию, можно выделить 3 периода: предлучевой, лучевой и послелучевой. На всех этих этапах большую роль играет высококвалифицированная работа медицинской сестры радиологического отделения.

Цель работы:

1. Определить особенности введения больных со злокачественными новообразованиями получающих лучевую терапию.

2. Разработать алгоритмы работы среднего мед. персонала в отделении радиологии.

Материалы и методы: статистические отчёты, карты лучевой терапии.

В 2009 году в отделении радиологии пролечено 949 больных, в условиях дневного стационара - 398. В отделении функционируют 4 аппарата для проведения лучевой терапии. На аппарате дистанционной гамматерапии «Агат С» закончили лечение 429 пациентов, на аппарате дистанционной гамматерапии «РОКУС АМ» пролечено 373 человека, на аппарате для внутримолостной лучевой терапии «Multisource» пролечено 86 больных, на аппарате близкофокусной рентгенотерапии «Gualmei» - 250 больных.

Для улучшения работы среднего медицинского персонала в работе с пациентами определены алгоритмы.

Предлучевой период. В этот период обычно проводят дополнительные исследования с целью уточнения локализации опухоли, а также подготовка больного к лучевой терапии. Предлучевая подготовка продолжается 1-2 дня. За указанное время больной адаптируется к условиям клиники (организация режима, питания). Персонал отделения проводит индивидуальные беседы с каждым пациентом о сущности лучевой терапии и возможностях снижения и предупреждения лучевых реакции.

Лучевой период. Это время прохождения самого курса облучения. При близкофокусной рентгенотерапии он занимает 2 – 3 нед., при дистанционной гамма-терапии – 4 – 8 нед.

Предупреждение общей лучевой реакции включает назначение полноценного питания, витаминотерапии.

Для предупреждения местных лучевых реакций и повреждений кожу обычно обрабатывают растительными и животными маслами, начиная с 8-10 дня.

Больным, страдающим сердечно – сосудистыми заболеваниями, необходимо назначить сосудорасширяющие и кардиотропные средства.

При проведении лучевой терапии больным с опухолями полости рта ежедневно назначают полоскание рта с раствором натрия гидрокарбоната.

Для профилактики повреждений слизистой оболочки верхних дыхательных путей проводятся ингаляции с персиковым маслом. Для профилактики повреждений слизистой оболочки рта, пищевода, гортани рекомендуется 10-15 гр. сливочного масла 2-3 раза в день держать во рту. При проведении лучевой терапии по поводу рака прямой кишки или шейки матки для уменьшения механического раздражения слизистой оболочки прямой кишки необходимо с первых дней лечения систематически проводить предупреждение запоров.

Результаты и выводы: таким образом, использование разработанного алгоритма работы среднего медперсонала в отделении радиологии позволяет избежать осложнений лучевой терапии.

СЛУЧАЙ АЛЬВЕОКОККА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ, ИМИТИРУЮЩИЙ ОПУХОЛЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ

*Кравчук В.А., Гимадиева Г.М., Боромбаев И.У.
КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», Центральная больница учреждения АП 162/2, г. Павлодар*

Актуальность: появление объемного процесса в области шеи обычно вызывает серьезные опасения у больного и лечащего врача. В этом случае больные или члены их семьи почти всегда думают о злокачественном процессе, но на самом деле он является только частью широкого спектра патологии, которую должен дифференцировать врач. Для того чтобы оценить все возможные варианты диагноза, обследование следует проводить последовательно и систематично. Нужно рассматривать как нормальные анатомические варианты, так и инфекционные заболевания, врожденные аномалии, доброкачественные и злокачественные опухоли. Дифференциальная диагностика объемных образований в области шеи очень важна, так как существенно влияет на выбор наиболее эффективного метода лечения. Диагностическая и лечебная тактика у больных с объемными образованиями в области шеи зависит от возраста больного, локализации образования и анамнеза заболевания. Альвеококкоз (синоним: альвеолярный эхинококкоз, многокамерный эхинококкоз) — гельминтоз с преимущественным поражением печени. Альвеококк имеет определенное географическое распространение. Встречается в Сибири, Якутии, Казахстане, Башкирии, Татарии, Киргизии.

Цель работы: Показать необычный случай имитирующий опухолевую патологию шеи.

Материалы и методы исследования: История болезни пациента Г.

Пациент Г., 27 лет поступил в ЦБ АП 162/2 с жалобами на слабость, субфебрильную температуру, наличие объемного малоподвижного образования на шее справа. Образование отмечает в течение 3 лет, постепенно увеличивалось, неоднократно обследовался по месту содержания направлен в хирургическое отделение для оперативного лечения с диагнозом ЛГМ с поражением шейных лимфоузлов справа. В условиях ЦБ АП 162/2 проведено обследование: рентгенография ОГК, УЗИ ОБП, консультация терапевта, клинические анализы – патологии не выявлено. Пункция образования не проводилась из-за расположения под сосудисто-нервным пучком шеи. Пациенту планировалась операция типа Крайля справа. При проведении операции 07.08.10. При мобилизации образования установлен переход его на верхнее средостение, при выделении выявлена фиброзная капсула, опухолевый характер поражения вызвал сомнения, образование в пределах здоровых тканей удалено, на разрезе заполнено множественными «кистами» (альвеококк). Остаточная полость обработана формалином 10%, установлен дренаж. Дренаж удален на третьи сутки. Гистологическое заключение № 43121 от 16.08.10. - Альвеококкоз мягких тканей. Послеоперационный период протекал гладко, швы сняты на 10-е сутки.

Результаты и выводы: при сомнительной клинической картине диагностическая операция с гистологическим исследованием имеет решающее значение для постановки диагноза. В данном случае имело место атипичное течение альвеококкоза (отсутствует поражение легких и печени, нет четкой связи со стенкой пищевода).

АНАЛИЗ ПРИЧИН УСТАНОВЛЕНИЯ IV СТАДИИ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Кравчук В.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: рак легкого в течение многих лет занимает первое место структуре онкологической заболеваемости, уровень IV стадии при раке легкого обуславливает высокие показатели запущенности в большинстве регионов.

Цель работы: анализ и изучение причин установления IV стадии при раке легкого.

Материалы и методы исследования: амбулаторные карты пациентов с установленной IV стадией рака легкого.

Проведен анализ амбулаторных карт за последние 3 года пациентов, которым была установлена IV стадия рака легкого. За 3 года было 276 пациентов.

Работающие составили только 10%, остальные либо пенсионеры, либо не работающие. При анализе возрастных показателей: в возрасте до 60 лет – 29%, в возрасте 60-69 лет – 32%, старше 70 лет – 39%.

Все пациенты взятые на учет с IV стадией процесса умерли в первый год от момента установления диагноза. В 56% случаев запущенность была установлена в связи отдаленными метастазами, при чем в 35% случаев отмечались множественные метастазы. По локализации метастазы распределились следующим образом: в кости, по плевре, в билатеральное легкое – по 21%, головной мозг и отдаленные лимфоузлы – по 10-11%, в мягкие ткани, печень и др. – 16%. В 13 случаях было установлено развитие рака легкого на фоне другой онкологической патологии, что составило чуть менее 5%.

При анализе длительности обследования до установления диагноза выявлено: обследование до 3-х месяцев – 60%, от 3-х до 6 месяцев – 15%, более 6 месяцев – 25%.

Результаты и выводы: Среди запущенных пациентов преобладают пациенты старших возрастов, которые не проходят

систематического профилактического обследования. Более 50% пациентов при установлении диагноза имели отдаленные метастазы, большая часть которых в пределах грудной клетки, отмечается высокий процент поражения головного мозга. Четкой связи между длительностью обследования и стадий процесса не установлено, что по-видимому связано с высокой биологической активностью рака легкого.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА ЛЕГКОГО В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-2009 ГОДАХ.

*Кравчук В.А., Сулейменов М.К., Буть Л.Г.
КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: в Республике Казахстан северо-восточные регионы лидируют по уровню онкологической заболеваемости. Заболеваемость в этом регионе превышает средние республиканские показатели за 20-30%. В структуре при этом в течение последних 40 лет преобладает рак легкого. Если в 70-80 годы отмечался повсеместно значительный прирост заболеваемости раком легкого, по данным различных авторов в 2-3 раза за 10-летие. То в 90-е и «нулевые» годы отмечается стабилизация эпидемиологических показателей рака легкого, а в ряде стран в основном странах Европы снижение.

Цель исследования: анализ и изучение статистических показателей рака легкого в Павлодарской области в 1990-2009 годах.

Материалы и методы исследования: статистические отчеты КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», конъюнктурный обзор деятельности.

При анализе заболеваемости раком легкого отмечается его стабилизация в относительных цифрах, а в абсолютных даже уменьшение, что связано демографическими изменениями населения области. Изменилось положение рака легкого и в структуре заболеваемости, он по-прежнему занимает первое место, но процентное соотношение его к остальным опухолям становится меньше. Так в 1990 году рак легкого составлял 18,1%, в 1999 году только 14,9%, в 2009 году 13,6%. Заболеваемость практически не изменялась и колебалась от 34 до 39 на 100 000 населения. Смертность от рака легкого сохраняется высокой, но отмечаются моменты стабилизации, а в последние годы и снижения, начиная с 2002 года (с 34,9 до 30,8). Если в 90-е годы отмечалось снижение удельного веса I-II стадии процесса и нарастание больных с IV стадией. То в 2000 годы в связи с внедрением единых стандартов диагностики и лечения, улучшения финансирования здравоохранения наметилась обратная динамика. (I-II стадии 1990 – 20%, 1997 – 6%, 2003 – 8%, 2009 – 24,5%, а IV стадия 1990 – 38%, 1999 – 48%, а с 2001 года неуклонно снижалась с 46,2 до 26,8%). Аналогичная ситуация с однолетней летальностью, так в 90-е годы отмечалось увеличение с 65 до 75%, то в 2009 году однолетняя летальность при раке легкого составила 61,7%. Соотношение мужчин и женщин практически не изменилось и составило 6,6:1. Стандартизованный показатель заболеваемости для мужчин составил 74,55, для женщин – 10,25. За отчетный период больные в возрасте до 60 лет составили только 30,8%, в возрасте 60-64 года – 25,2%, 65-69 лет – 15,5 %, старше 70 лет 28,5%, стандартизованный показатель заболеваемости составил соответственно в возрасте до 60 лет 14,6, 60-64 года – 203,5, 65-69 лет – 221,7, старше 70 лет – 257,6. При этом клинически значимую сопутствующую патологию имели 81% больных (колебания по годам от 74,2 до 84,9%), основную массу составили заболевания сердечно-сосудистой системы 39,8%, хронические заболевания легких 19,6%, заболевания ЖКТ 9,4%, патология почек 7,4%, сахарный диабет 2,2%, а сочетание с туберкулезом 2,3%.

Заключение и выводы: за последние 20 лет серьезных успехов в диагностике и лечении рака легкого добиться не

удалось как в нашем регионе, стране, СНГ. В связи с внедрением стандартов диагностики и лечения заболеваний, улучшением финансирования здравоохранения положительные подвижки всё-таки есть: несколько уменьшилась смертность, увеличился процент пациентов с малыми стадиями, процент пациентов получивших специальное лечение. По-прежнему актуальны вопросы возраста больных, сопутствующей патологии у них, высоких темпов роста опухолей легкого.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ ПРИ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ИСХОД ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Лозовой В.В.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: по сводной статистике Шалимова А.А. (1987, Киев) послеоперационная летальность при операциях на пищеводе и кардиальном отделе желудка менялась в течение последних 50 лет, так в 1940-49 гг. она составляла более 40%, 1950-59 гг. – 30%, 1960-69 – 25%, а в 70-80-е годы составляла 19%. Улучшение результатов лечения связаны с наработкой методик операций, созданию школ хирургов, более четким ведением операционного и послеоперационного периода в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Цель работы: провести анализ влияния различных методов послеоперационного обезболивания на интенсивность послеоперационного болевого синдрома (ПБС), послеоперационную летальность, частоту сердечно-сосудистых осложнений, а также длительность послеоперационного пареза кишечника.

Материалы и методы: истории болезни пациентов торакального отделения за 2005 – 2009гг., которым были проведены операции на пищеводе и кардиальном отделе желудка при раке. За 5 лет в торакальном отделении Павлодарского областного онкологического диспансера проведено 67 радикальных операций при раке пищевода и кардиального отдела желудка с переходом на пищевод. Средний возраст оперированных больных составил 59 лет, в то время как средний возраст больных взятых на учет 65 лет. Все больные были разделены на 2 группы, группы различались по применяемым методам интра – и послеоперационного обезболивания: в 1 группе во время операции проводили общую анестезию, для послеоперационного обезболивания в 1 группе использовали системное введение опиоидных анальгетиков по требованию, во 2 группе на интраоперационном этапе использовали высокую (уровень Th III-V) эпидуральную анестезию (ЭА) в качестве анальгетического компонента общей анестезии, для послеоперационного обезболивания – длительную ЭА с сочетанным введением местного анестетика (0,5% лидокаин) и опиоида. Был проведен анализ влияния различных методов послеоперационного обезболивания на интенсивность послеоперационного болевого синдрома (ПБС), послеоперационную летальность, частоту сердечно-сосудистых осложнений, а также длительность послеоперационного пареза кишечника.

Результаты и выводы: интенсивность ПБС во 2 группе была значительно ниже, чем в 1 группе. Также во 2 группе была ниже частота сердечно-сосудистых осложнений (ЭКГ признаки ишемии миокарда, нарушения сердечного ритма.) Процент осложнений в 1 группе составил 14,2%, летальность составила 3,5%. Во 2 группе процент осложнений 12,8%, летальность 1,6 %. Общий процент осложнений составил 13,5%, летальность составила 2,5%. Во 2 группе было отмечено значительное снижение продолжительности послеоперационного пареза кишечника.

Применение ЭА на интраоперационном этапе повышает эффективность анестезиологической защиты от операционной травмы и снижает вызванную операционной травмой

гипервозбудимость спинальных нейронов, что существенно уменьшает выраженность негативных рефлекторных воздействий на сердечно-сосудистую систему. Применение продленной ЭА оказывает выраженное влияние на моторику ЖКТ при торакоабдоминальных операциях, что способствует раннему началу энтерального питания пациентов. Вышеуказанные факторы, а также снижение выраженности операционного стресс-ответа при применении высокой ЭА способствует снижению послеоперационной летальности. Для выздоровления особое значение имеет также комплекс мер предоперационной подготовки и особенно послеоперационного ведения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОФЛЮРАНА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ В ОНКОХИРУРГИИ (ТВБА)

Лозовой В.В.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: адекватная анестезия недостижима без правильного режима доставки анестетика в кровоток. Если анестетик вводят дробными дозами в/в струйно через определенные промежутки времени, то кривая концентрации препарата в плазме выглядит как чередование пиков и провалов. Пики проявляются чрезмерной глубиной анестезии и побочными эффектами анестетика, провалы – слишком поверхностной анестезией, сопряженной с риском восстановления сознания. Если анестетик вводить слишком часто, то он может кумулировать, что замедляет пробуждение. При ТВБА необходимо вводить два препарата – гипнотик и анальгетик, поэтому существует много стратегий инфузии. Но интенсивность ноцицептивной (хирургической) стимуляции изменяется во времени, поэтому инфузия анальгетика в дозе, эффективно подавляющей наиболее интенсивное болевое раздражение, может привести к относительной передозировке опиоида и замедлить восстановление самостоятельного дыхания в конце операции. Недостатком методов, основанных на использовании наркотических средств для поддержания общей анестезии, является тот факт, что от анестезиолога требуется большое умение, чтобы обеспечить равномерный эффект анестезии в течении операции.

Цель работы: провести сравнительный анализ применения ингаляционного анестетика Изофлюрана как дополнительного компонента при (ТВБА) тотальной внутривенной анестезии в онкохирургии.

Материалы и методы: опыт применения Изофлюрана как дополнительного компонента при (ТВБА) тотальной внутривенной анестезии в онкохирургии, в работе анестезиолога – реанимационного отделения Павлодарского онкодиспансера за 5 лет.

Проведено - 278 ТВБА + Изофлюран анестезий на органах пищеварения, органах грудной клетки, органах мочеполовой системы у больных в возрасте от 36 до 79 лет, что составило 8,5% от общего числа проведенных анестезиологических пособий в этой группе больных. Применение Изофлюрана как дополнительного компонента при (ТВБА) определялось в процессе проведения ТВБА, вводный наркоз TiNa 2.5% , основной наркоз (морфин (фентанил) + кетамин) с применением мышечных релаксантов, с интубацией трахеи, O₂, ИВЛ. У всех больных в анамнезе артериальная гипертензия 1-2 ст., а также терапия ингибиторами АПФ, бета – блокаторами. У них также отмечалась выраженная гипертензивная реакция на неадекватную аналгезию во время операции. Подача Изофлюрана во время анестезии составляло от 1,5 об% - до 0,3 об%.

Результаты и выводы: у всех больных после применения Изофлюрана отмечалась устойчивая гемодинамика, без

чередование пиков и провалов, что часто отмечается при обычной болюсной ТВБА. Основное количество больных которым применялся форан имеют возраст от 45 до 60 лет. По окончании операции практически у всех больных наблюдался мягкий выход из наркоза, быстрее восстанавливалось адекватное самостоятельное дыхание. Расход наркотических анальгетиков и гипнотиков за период анестезии особо не изменялся. При использовании изофлюрана является мощным дыхательным депрессантом и снижает артериальное давление за счет общепериферического сопротивления. Возможность применения у больных со стойкой артериальной гипертензией, не увеличивая дозу наркотических анальгетиков и гипнотиков что приводит к более быстрому восстановлению самостоятельного дыхания в конце операции. Применение изофлюрана дополнительного компонента при (ТВБА) Тотальной внутривенной анестезии, является методом выбора анестезиологического пособия у онкологических больных.

РОЛЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Сатабаев М.Т.

КГКП «Поликлиника №1 г. Павлодара», г. Павлодар

Актуальность: раннее выявление онкологических заболеваний является залогом успешного лечения, содействует улучшению основных онкологических показателей (снижение смертности, увеличение пятилетней выживаемости, снижение однодневной летальности).

Цель работы: демонстрация значимости деятельности врачей и среднего медицинского персонала городской поликлиники в раннем выявлении онкологических заболеваний.

Материалы и методы: методические разработки по диагностике рака, отчёты о выполнении скрининговых программ, проводимых в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 607 за 2008 – 2009 годы.

Городская поликлиника № 1 г. Павлодара обслуживает население численностью около 80000 человек. Основными задачами для улучшения онкологической ситуации на прикрепленной территории являются: организация ранней диагностики злокачественных новообразований; диспансеризация лиц групп повышенного риска; оказание медицинской помощи онкологическим больным по рекомендациям областного онкологического диспансера; восстановительное лечение и реабилитация. К приоритетным направлениям работы относятся организация ранней диагностики рака; санация предраковых заболеваний у лиц из групп повышенного риска; направление всех выявленных больных или больных с подозрением на онкопатологию в онкологический диспансер; оказание восстановительного лечения в амбулаторных условиях. Поликлиника оснащена медицинской аппаратурой, позволяющей проводить обследования: клинические, биохимические, рентгенологические; эндоскопические; функциональные. В смотровом кабинете и в женской консультации проводится забор материала для проведения цитологических исследований в централизованной цитологической лаборатории. Биопсийный материал, взятый врачами - хирургами и гинекологами, доставляется на морфологическое исследование в патогистологическую лабораторию на договорной основе. Все перечисленные обследования проводятся в рамках ГОМБП. Реализуемая в Республике Программа по ранней диагностике рака молочной железы и рака шейки матки позволила нам планомерно обследовать в 2008г. 5028 женщин декретированного возраста (3300 обследовано цитологически, 1728 – маммографически), в 2009г. – 5100 (3000 – цитологический скрининг, 2100 – маммографический скрининг). При проведении маммографического скрининга в 2008г. выявлен 1 случай рака молочной железы, 758 случаев

доброкачественной гиперплазии молочной железы и доброкачественных узловых образований. В 2009г. выявлено 3 случая рака молочной железы, другой патологии - 732. Проведение цитологического скрининга позволило выявить в 2008г. патологию у 677 женщин, в 2009г. – у 667 женщин. Процент выявленной патологии составил по годам соответственно 20,5% и 22,2%. Лечебные мероприятия сводятся к санации и лечению групп повышенного риска и проведению симптоматической терапии больных с IV ст. заболевания, лечению выраженного болевого синдрома. Критерием качества проводимых мероприятий является увеличение числа санированных больных с одно-временным уменьшением числа онкобольных с III-IV стадиями заболевания из числа диспансеризуемых групп риска.

Заключение и выводы: в последнее время государство уделяет много внимания раннему выявлению заболеваний, в том числе и онкологических, приводящих население к инвалидности. Для улучшения онкологической ситуации каждый житель прикрепленной к поликлинике территории, обязан ежегодно пройти минимальный набор медицинских обследований. Профилактический осмотр должен способствовать выявлению начальной формы онкологического заболевания, лечение которого, несомненно, более результативно при его начальных стадиях.

ПРОБЛЕМА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛЕГКИХ.

Сулейменов М.К.

*КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: Рак легкого во многих индустриально развитых странах представляет одну из самых актуальных проблем клинической онкологии. Он является наиболее частой злокачественной опухолью и основной причиной смерти от онкологических заболеваний. В Павлодарской области отмечается прирост показателя заболеваемости на 9% и смертности на 5% за последние 15 лет.

Цель работы: проанализировать удельный вес сопутствующих заболеваний у больных раком лёгкого и их влияния на возможности лечения.

Материалы и методы: истории болезни, статистические показатели.

Для рака лёгкого характерны высокий процент запущенности и одногодичной летальности. Одногодичная летальность в Павлодарской области колеблется от 62 до 75% в различные годы, хотя в 2000-х годах постепенно снижается, но остается на высоких цифрах и составляет 62-63%, то есть в первый год при постановке диагноза умирают все больные с IV стадией и половина больных с III стадией процесса. По нашим данным, специальное лечение получают 40 - 44% больных взятых на учет, при этом хирургическое и комбинированное лечение не более 10 - 12%. Отказы от лечения составляли 6 - 8 %. Противопоказания для специального лечения составлялись 12 - 15%. Больные с IV стадией процесса составляют до 50%.

По данным ВОЗ неуклонно растет количество населения старших возрастов, и, как следствие, заболеваемость онкологической патологией. За последние 5 лет больные раком легкого в возрасте до 60 лет составили 30,8%, в возрасте 60 - 64 года – 25,2%, 65 - 69 лет – 15,5 %, старше 70 лет 28,5%. Стандартизованный показатель заболеваемости составил соответственно в возрасте до 60 лет 14,6; 60-64 года – 203,5; 65-69 лет – 221,7; старше 70 лет – 257,6.

Среди онкологических больных немалую долю составляют пациенты с серьезными сопутствующими заболеваниями, значительно снижающими функциональные резервы и в большой мере определяющими риск лечения.

За последние 5 лет клинически значимую сопутствующую патологию имели 81% больных раком легкого (колебания по

годам от 74,2 до 84,9%).

Основную массу составили заболевания сердечно - сосудистой системы (39,8%), что объясняется преклонным возрастом пациентов. При анализе пациентов с сопутствующей сердечно - сосудистой патологией примерно одинаковое количество составляли пациенты с ИБС и артериальной гипертензией, часто имели место сочетание этих патологий, очень редко (единичные случаи) отмечалась врожденная патология, поражение клапанного аппарата и др. Одним из предрасполагающих факторов в отношении развития рака легкого являются хронические заболевания легких, у наших пациентов они составили 19,6%. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта составляют 9,4%, среди них преобладают поражения гепатобилиарной системы (до 95%). Патология почек встречается в 7,4% случаев. Сахарный диабет зарегистрирован в 2,2%, а сочетание с туберкулезом - 2,3%. Среди прочей патологии преобладали поражения нервной системы, особенно центральной.

Результаты и выводы: таким образом, среди заболевших РЛ около 70% лиц старше 60 лет, как следствие имеют место наличие выраженной сопутствующей патологии (до 81% от числа заболевших), которая в купе с поздней диагностикой не позволяет проводить радикальное лечение основной массе больных. Выбор оптимальной лечебной тактики у онкологических пациентов - сложный и индивидуальный процесс. Для оценки функционального состояния онкологического больного необходимо использование многофакторной шкалы, охватывающей все сферы жизнедеятельности.

ОБЫР АУРУЫН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ТИІМДІЛІГІ

Сандыбаев М.Н., Зейнелова Л.Т.,

Жұмықбаева Н.К., Бегатарова Қ.Н.

Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері

Академик Н.Н.Петровтың (1947) пікірі бойынша обырдың себептері туралы біз көп білеміз, обырға қарсы күрес мәселесін алдын алу релсіне қою мүмкіндік қана емес, қажеттілік. Бірақ, тұрғындар арасында жүргізілетін обырға қарсы ағартушылық жұмыстар қазақстандағы алдын алу (профилактикалық) жұмыстарды жүзеге асыратын бірден – бір бағыт болып табылады.

Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері мамандары Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университеті онкология кафедрасымен бірлесе отырып, диспансердің сыртқы қызметіне қатысты обырға қарсы күресті ұйымдастыру жүйесін жасады.

Зерттеу мақсаты. Семей өңірінде 2008 -2009 жыл аралығы кезеңдегі обырға қарсы күрестің тиімділігіне зерттеу жүргізу.

Материалдары мен әдістері. Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансеріндегі 2008-2009 жыл аралығы кезеңіндегі деректер бойынша қатерлі ісіктерді ерте анықтау және асқынудың статистикалық көрсеткіштеріне салыстырмалы түрде талдау жүргізілді. 2005-2009 жылдар аралығында онкология диспансерінің қызметкерлерімен 79 мақала, 98 теледидардан және радиодан қатерлі ісіктерді алдын-алу мақсаты жөнінде 30 баяндама жасалды.

Қорытынды. Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері мамандары Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университеті онкология кафедрасымен бірлесе отырып, диспансердің сыртқы қызметіне қатысты обырға қарсы күресті ұйымдастыру жүйесін жасады. Сонымен, статистикалық талдау деректері негізінде мынадай қорытынды жасауға болады, онкологиялық диспансер мамандары жүргізіп жатқан мазмұны мен түрі жағынан әртүрлі ағартушылық жұмыстар Семей аймағындағы қатерлі ісіктердің ерте анықтауды жақсартуға, онкологиялық аурулардың асқину жағдайларын төмендетуге және қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың өміршеңдігін ұзартуға қол жеткізуге мүмкіндік туғызды.

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Зейнелова Л.Т., Сандыбаев М.Н., Челдыбаева Т.И.
Региональный онкологический диспансер г. Семей,
Республика Казахстан

Актуальность. Глава государства в своем Послании «Новое десятилетие - Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана» отметил, что здоровье народа - это неотъемлемая составляющая успеха Казахстана в достижении своих стратегических целей. В условиях экономических преобразований роль, функции и организационные формы деятельности сестринского персонала меняются в соответствии с новыми задачами, стоящими перед здравоохранением. В настоящее время в системе Министерства здравоохранения Республики Казахстан работают 119884 средних медицинских работников, что более чем в 2,4 раза больше врачей. Сегодня это соотношение врачебного и среднего медперсонала говорит о том, что в современной системе здравоохранения наряду с врачебной, эффективность оказания медицинской помощи зависит от применения модернизированной сестринской деятельности, направленной на повышение качества оказания медицинской помощи, путем осуществления организационных сестринских технологий.

Управлять качеством сестринской помощи, по мнению Дороти Холл, можно лишь тогда, когда деятельность сестер изучена, структурирована, нормирована, а значит, может быть оценена в соответствии со стандартом.

Цель: Анализ качества работы среднего медицинского персонала на основе изучения анкет.

Материалы и методы: Всего за период с 2005-2009 гг. было изучено 2134 анкеты экспертных оценок сестринской помощи, 11971 анкета опроса пациентов о качестве оказываемой сестринской помощи.

На базе Регионального онкологического диспансера г. Семей работают 158 средних медицинских работников, из них 75% медсестер имеют квалификационную категорию, с высшим медицинским образованием 8 человек.

Для мониторингирования действий и результатов по принятой технологии сестринского процесса в лечебных отделениях стационара с 2005 года были внедрены «Карты сестринского наблюдения больных». Проведение анализа с использованием разработанных карт оценки сестринской деятельности улучшает качество медицинской специализированной помощи онкологическим больным, позволяет оценить качество работы структурных подразделений лечебно-профилактических учреждений. Предложенные механизмы внедрения в практику новых медицинских технологий обеспечивают проведение всесторонней и качественной оценки, учитывающей клинические, профессиональные и этические аспекты.

С целью изучения мнения пациентов об удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи проводится анкетирование пациентов по качеству ведения, культуре обслуживания, наличию информации по видам услуг, организации и качеству питания. Данные анализа результатов опроса оказывают несомненную роль в корректировке работы сестринской службы.

Результаты и выводы: Систематический анализ мнения больных показывает, что, начиная с 2005 года, удовлетворенность пациентов деятельностью среднего медицинского персонала в РОД г. Семей характеризуется ростом на 33,3%. При этом наиболее значительная положительная динамика наблюдалась в отделениях, имевших низкие показатели.

Таким образом, применение технологических карт оценки деятельности медицинских сестер способствовало повышению качества работы среднего медицинского персонала.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО III СТАДИИ

Абисатов Х.А., Балтабеков Н.Т., Нсанов Ж.К.
Казахстанско – Российский медицинский университет,
Алматинский городской, Атырауский областной
онкологический диспансер

Актуальность. Ведущим методом лечения рака легкого является хирургический, однако отдаленные результаты его нельзя считать удовлетворительными, так как от 30 до 50% больных, перенесших радикальные операции, погибают в течение первых трех лет от рецидива и метастазов (Трахтенберг А.Х. с соавт., 1996г., Жарков В.В.с соавт., 2003г., Стилиди И.С. с соавт., 2004г., Фокеев С.Д. с соавт., 2006г.). В целях улучшения продолжительности жизни больным проводятся комбинированные и комплексные методы, однако по данным литературы показатели отдаленных результатов разноречивые, поэтому мы хотим поделиться опытом и результатом применения вышеуказанных методов лечения больных раком легкого.

Цель – улучшение результатов лечения больных раком легкого III стадии на основании сравнительной оценки современных методов лечения. Материал и методы исследования. Нами проанализированы истории болезни 666 больных раком легкого, выписанных из стационара, из них 285 больных подвергались радикальному хирургическому лечению, 236 больных – адьювантной полихимиотерапии, 45 больных – неоадьювантной лучевой терапии интенсивно – концентрированным методом (ежедневно) РОД-4Гр, до СОД 20Гр, через 1-3 дня операция. Адьювантная лучевая терапия в РОД-2Гр до СОД-45-50Гр, а также 50 больным с операбельным раком легкого III стадии, отказавшимся от операции или имевшим противопоказания к ней и получившим дистанционную гамма – терапию расщепленным курсом по радикальной программе. Адьювантная ПХТ проводилась больным раком легкого через 3 – 4 недели после операции, 6 – 8 курсов в течение двух лет с применением циклофосфана, гемзара, карбоплатина, метотрексата, винкристина. Прослеженность свыше 5 лет составила 100%.

Результаты исследования и заключение. Хирургическое лечение, как самостоятельный метод более или менее эффективен при I стадии, 5 – летняя выживаемость равнялась 65,2%, из них при дифференцированных морфологических формах – 76,8%, мало- и недифференцированных формах – 62,5%, при II стадии – аналогичные показатели – 43,6%, 50,0% и 40%, при III стадии – 9,7%, 13,0%, 6,8% соответственно. Следует отметить, что наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах резко ухудшает прогноз при всех гистологических формах.

- При проведении более 6 курсов адьювантной полихимиотерапии больным с III стадией трехлетняя выживаемость составила 45,8+/-6,4%, после одного хирургического лечения – 36,2+/-5,6%, при дифференцированных формах – соответственно 54,8+/-6,5% и 24,8+/-5,4%, низко- и недифференцированных – 38,7+/-5,8% и 17,1+/-6,4%.

- При применении послеоперационной лучевой терапии больным с III стадией трехлетняя выживаемость равнялась 44,1+/-3,5%, после хирургического лечения – 36,2+/-5,6%, при дифференцированной форме 48,0+/-6,5%, 24,3+/-5,4%, низко- и недифференцированной форме – 27,5+/-3,6% и 12,5+/-5,8%.

- После расщепленного радикального курса лучевой терапии трехлетняя выживаемость составила 14,0+/-4,9%, при дифференцированных формах – 16,4+/-4,8%, низко- и недифференцированных формах ни одной больной не прожил более двух лет.

Таким образом, исходя из полученных данных о выживаемости больных раком легкого следует заключить, что выбор оптимального метода лечения остается очень сложной проблемой, в которой все отчетливее выступает необходимость индивидуализации тактики лечения в зависимости от основных прогностических факторов. Хирургическое лечение как самостоятельный метод эффективен при ранних стадиях в условиях отсутствия метастазов в регионарных лимфатических узлах при всех морфологических формах, а при IIb, III стадии малоэффективен, так как расширение объема оперативного вмешательства путем резекции соседнего анатомического образования с регионарной лимфодиссекцией существенно не улучшает продолжительность жизни больных при всех морфологических формах.

Адьювантные курсы полихимиотерапии и лучевой терапии позволяют заметно улучшить результаты хирургического лечения при раке III стадии с метастазом в регионарных лимфатических узлах. Неоадьювантная лучевая терапия эффективна при отсутствии метастазов.

При III стадии рака легкого лучевая терапия, проведенная расщепленным курсом по радикальной программе, носит паллиативный характер, где трехлетняя выживаемость при дифференцированных формах составляла 16,4+4,8%, низкая и недифференцированных формах – 0%.

Следовательно, для улучшения отдаленных результатов лечения рака легкого во IIb и III стадиях необходимы совершенствования существующих и разработка новых схем адьювантных курсов полихимиотерапии с использованием современных противоопухолевых препаратов, таких, как карбоплатин, таксотер, гемзар, навельбин и др..

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ СЛУЧАЙНО ВЫЯВЛЕННЫХ ОПУХОЛЯХ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Бекмухамбетов Е.Ж., Дюсембеков С.Т., Койшыбаев А.К., Симбатов Т.К., Ешимов С.А.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней

Актуальность. По данным литературы гормонально неактивные опухоли надпочечников «клинически немые» или же инсиденталомы описывались как случайные находки при аутопсии по различным причинам. В последние десятилетия после внедрения в клиническую практику таких методов уточняющей диагностики, как УЗИ, КТ и ЯМРТ появились публикации, указывающих, что у 0,5 до 5 % больных, не имеющих клинической симптоматики нарушения функции надпочечников, при проведении вышеперечисленных методов обследования выявляются различные опухоли надпочечников. Среди них чаще всего встречаются доброкачественные образования, так по данным M.S. Gross и B. Shapiro (1993) доброкачественные аденомы встречаются с частотой 1:4000, а злокачественные меньше чем 1:250 000. Кроме первичных опухолей выявляются и метастатические поражения рака легких, молочной железы и др. Из редких опухолей выявляются нейрофиброма, гамартома, тератома, кисты и др.

Цель исследования. Значение хирургического лечения при случайно выявленных аденомах коры надпочечника.

Материал и методы исследования. По нашим данным за период с 2000 по 2009 годы были диагностированы 3 случая больных с «немыми» формами опухолей надпочечников, при этом все случаи выявлены при профилактических осмотрах. Клинических проявлений характерных для опухолей надпочечников больные не предъявляли. По данным УЗИ и компьютерной томографии размеры опухолей варьировали от 3 см до 4,5 см, данных за диссеминацию процесса в дооперационном периоде не выявлено. Всем больным проведено хирургическое лечение в объеме адреналэктомии с

опухолью. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. При морфологическом исследовании у больных выявлены аденомы надпочечника. Все больные выписаны под динамическое наблюдение онколога и эндокринолога по месту жительства, за время наблюдения состояние больных без ухудшения.

Выводы. Таким образом, при «немых» опухолях надпочечников, ведущим методом лечения является хирургический.

БАСТАПҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК (БМСК) ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ИНОВАЦИЯЛАУ.

Жұмағалиев Д.Ж.

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасында қатерлі ісік ауруларынан өлім, қан айналымы ауруы және жарақаттан соң, үшінші орынға ие. Жалпы республикамызда көлемінде қайтыс болғандардың жетіншісі қатерлі ісік аурунан қайтыс болған. Еліміздің қатерлі ісікке қарсы күресуші мекемелерінде 2009 жылы 138823 (9742) астам адам есепте тұрса, оларды 100 000 халыққа шаққанда республикамызда 868,6 (ОҚО-401,5) көрсеткен. Жыл сайын елімізде 29 000 астам қатерлі ісік ауруымен тіркелсе, (ОҚО-2328), ал өлгендер саны республикамызда 17 000 жуық (ОҚО-1350) адам. Осылардың 45 пайыздан астамы еңбекке жарамды жастағылар. Сондықтан, қатерлі ісік ауруларын әлуметтік мәні бар аурулар қатарына жатқызуының өзі, біз онкологтар қауымына үлкен жауапкершілік артыратыны, әсіресе БМСК деңгейіндегі онкологиялық қызметті иновациялау керектігі, бұл қазіргі кезеңнің талабы.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша онкологиялық қызметтің жағдайын БМСК деңгейінде зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2005-2009 жылдар аралығында қатерлі ісік ауруларының сапалы көрсеткіштері аясында және де БМСК деңгейіндегі онкологиялық қызметтің жұмыс барысын талдау негізінде алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2009 жылы 2328 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса (100 000 халыққа шаққанда 98,7), ал 2005 жылы 2345 науқас (100 000 халыққа шаққанда 106,0) болған. Аурушандық 2005-2008 жылдар аралығында 92,8 дейін төмендегенімен 2009 жылы 98,7 қайта өскен. Қатерлі ісіктің асқынған түрімен 2005 жылы 474 науқас (20,2 пайыз) тіркелсе, 2009 жылы 443 науқас (19,0 пайыз), тек бір пайызға азайған. Бірақ, 2009 жылы облыс көлемінде Мақтаарал ауданында 26,1 пайыз, Шардарада 25,0 пайыз, Сарыағашта 22,1 пайыз, Кентау қаласында 22,3 пайызға жоғары болған. Өлім 2009 жылы 1350 науқас 55,6 (100 000 халыққа шаққанда) болса, 2005 жылы 56,6 қалыпты деңгейде, осыған қармастан, облыс көлемінде Төлеби ауданында 70,6, Арыста 68,7, Кентауда 68,2, Ордабасыда 64,1, Түлкібаста 62,8 жоғары көрсеткіштер болған, бұл осы ауданмен қалаларда өлімнің көптігі. Науқастардың ауырғыштығы 2005 жылы 7949 науқас 356,2 100 000 халыққа шаққанда, ал 2009 жылы 9742 науқас 413,3 өскен. Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2005 жылы 33,6 пайыз болса, ал 2009 жылы 45,1 пайызға өскен, бірақ облыс көлемінде ең төмен көрсеткіштер Түлкібас ауданында 34,1 пайыз, Созақта 35,3 пайыз, Арыста 36,3 пайыз, Ордабасыда 38,0 пайыз болған. Міне, осы көрсеткіштерді ескере отырып онкологиялық қызметті жақсарту мақсатында БМСК деңгейінде 2010 жылдың 7 айында бірнеше рет тексеру жүргіздік, әсіресе Созақ, Түлкібас, Ордабасы, Арыс аудандарында. Анықталған негізгі кемшіліктер тоқталсақ, бұл онкологтардың тұрақты жұмыс істемеуі, тез-тез ауысуы, әлде қосалқы түрде міндетін атқаруы. Диспансерлік есептің дұрыс жүргізілмеуі, науқастардың арнайы ем барысының толық

қадағаланбауы, созылмалы немесе қатерлі ісік алды, қатерлі емес ісіктердің сауықтыру процессі нашарлығы, дәрігерлердің арасында өз-ара әріптестік қарым-қатнастың жоқтығы және де ҚР ДСМ № 607,685 бұрықтарының орындалуы барысы қағаз жүзіндегі ойландырады

Сондықтан, онкологиялық қызметті жақсарту үшін БМСК деңгейінде жаңа жүйелі іс-шаралар ойластырып, ҚР ДСМ №206 26.05.1994 жылғы бұйрығына өзгерістер жасап, иновациялық жаңалықтар енгізу, бұл өмір талабы.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛА РАД В ЛЕЧЕНИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Астапкевич Л.А.

Городская больница №1, г. Астана

Поражение почек является наиболее частой висцеральной патологией (в 50-90% случаев) при множественной миеломе\ММ\ и одной из основных причин сокращения продолжительности жизни больных. Наиболее важное значение в развитии поражения почек и формировании ХПН при ММ имеют: гиперпродукция патологических легких цепей иммуноглобулинов с их накоплением в дистальных канальцах, последовательное прогрессирование парапротеинемии и протеинурии, что приводит к микроциркуляторным нарушениям, дистрофии эпителия почечных канальцев, развитию склероза и рубцовой деформации анатомических структур почек, а также гиперкальциемия, гиперкальциурия, фосфатурия, повышение уровня мочевины в сыворотке крови, диффузный амилоидоз.

В условиях гематологического отделения 2 пациентам с подтвержденным диагнозом Множественная миелома IIIB стадия \ данные морфологии, электрофореза белка, определение уровня креатинина в сыворотке, иммунологическое обследование\ проведены курсы полихимиотерапии по протоколу РАД \ Велкейд 1,3 мг\м² в\в - 1,4,8,11 дни, адриабластин 9 мг\м² в\в в течение 1-4 дней, Дексаметазон 40 мг в\в по 4 дня-3 блока \ с пер-спективой проведения в дальнейшем аутологичной трансплантации стволовых клеток.

Пациенты	1 пациент				2 пациент		
курсы	1 курс	2 курс	3 курс	4 курс	1 курс	2 курс	3 курс
Нв	50	84	91	95	62	87	82
Лейкоциты	5,0	7,1	6,3	5,2	2,6	2,5	3,7
Тромбоц.	219	290	261	236	27,4	103,3	55
СОЭ	68	50	36	31	75	60	52
Протеинур.	6,2	0,089	0,081	0,081	0,372	0,01	0,34
Белок Б-Д.	+	-	-	-	+	-	-
Общ\белок	83,4	72	68	75	112,6	94	95
М-град.	+	-	-	-	+	-	-
креатинин	563	172	156	144	644	370	424
мочевина	22,6	10,2	6,7	6,9	34,3	21	20
ЛДГ	638	1179	626	844	652	663	1314
СРБ	++++	отр	отр	отр	++++	отр	+++
КМ	Пл. кл - 23,8%				Пл. кл - 41,7%		
ОД	+				+ патолог. переломы		
печень	+9,0	+2,0	+3,0	N	+2,0	N	N
селезенка	133 x52	N	N	N	N	N	N

Белок Б-Д- белок Бенс-Джонса, КМ-костный мозг, ОД-остеодеструкция, пл.кл-плазматические клетки.

В результате проведенной терапии у пациентов достигнуто улучшение-восстановились показатели красной крови \отказ от трансфузии Эр-взвеси\, снизились показатели креатинина и мочевины, общего белка в крови и моче, купированы оссалгии. Отмечена хорошая переносимость протокола.

Протокол РАД можно рекомендовать как протокол первой линии у пациентов с множественной миеломой IIIB стадии.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Гофур-Ахунов М.А., Полатова Д.Ш., Нишонов Д.А.,
Хаитов Ф.Э., Каримова Н.М.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз,
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: Определить показатели маркеров пролиферации и апоптоза у больных с остеогенной саркомой трубчатых костей.

Материалы и методы: Обследованы 46 больных остеогенной саркомой в возрасте от 8 до 16 лет. В 26 наблюдениях опухоль локализовалась в бедренной кости и в 20 – большеберцовой кости.

В зависимости от рентгенологического проявления опухоли все больные подразделены на 3 группы: остеопластический тип – 4 (30,4%), остеолитический тип – 16 (34,8%), смешанный тип – 16 (34,8%) .

Для проведения молекулярно-генетического исследования использованы парафиновые срезы образцов опухолевой ткани с определением экспрессии генов p-53 и Ki-67 (фирма "Novo Castro", Великобритания).

Уровень пролиферации опухолевой ткани определяли по экспрессии гена Ki-67 маркера клеток, находящихся в митотическом цикле, а также определен уровень апоптоза по экспрессии мутационного гена p 53. Степень экспрессии оценивали поликоличественным способом: от 0 до 10% клеток с наличием окраски - отрицательная экспрессия, до 50% средняя экспрессия, свыше 50% сильная экспрессия.

Результаты: Нами изучены показатели ген - супрессора p-53 и ген пролиферации клеток Ki-67 в зависимости от пола и рентгенологического типа опухоли. Рентгенологически смешанном типе частота Ki-67 положительных опухолей составила - 64,2%, а отрицательных – 38,5% (16,9% - среди

мальчиков и 16,2% среди девочек). Митотический индекс оказался ниже в образцах смешанного типа опухоли (55% у мальчиков и 9,0% у девочек), но выше при остеолитическом и остеопластическом типах. При смешанном варианте опухоли установлен самый низкий уровень экспрессии гена mtp-53 (12,1% мальчиков и 7,7% девочек).

Самый высокий апоптотический индекс обнаружен при самом низком митотическом индексе. При этом среди мальчиков положительные реакции обнаружены у 15%, среди девочек у 45,5%.

Заключение: Высокая экспрессия ген - супрессора p53 обнаружена при остеолитическом типе остеогенной саркомы, наименьшая при смешанном. Экспрессия гена Ki-67 и p53 не зависит от рентгенологического типа опухоли.

АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА СРЕДИ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АСБОЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дауренов Б.Б.

Южно-Казахстанский областной онкологический
диспансер, г. Шымкент

Борьба со злокачественными новообразованиями является одной из актуальных задач в области здравоохранения. В настоящее время в ее решении большое внимание уделяется первичной профилактике, а именно, выявлению и устранению факторов внешней среды, в том числе производственных, способствующих возникновению онкологических заболеваний. Распространенным профессиональным канцерогенным фактором риска является ас-

бест, который по классификации Международного Агентства по изучению рака относится к первой группе канцерогенов.

Нами проведена оценка реальной онкологической опасности у работающих Шымкентского производства асбоцементных конструкции и разработка научно обоснованных дифференцированных мероприятия предупредительного характера.

Данные о состоянии производственной среды за период с 1999 по 2006 год свидетельствуют о том, что на основных рабочих местах отмечается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) асбестосодержащей пыли.

Наибольшее загрязнение асбестосодержащей пылью наблюдается в формовочном цехе, где ее концентрация превышает гигиеническую норму до 2,7 раза, а в аппаратном цехе превышение ПДК составляет до 2,15 раза. За исследуемые годы загрязненность атмосферного воздуха формовочного цеха повысилась на 0,9%, а в аппаратном цехе снизилась на 0,5%. Результаты изучения онкологической смертности свидетельствуют о том, что у работающих данного производства повышен риск развития злокачественных новообразований.

Статистически значимыми являются различия между стандартизованными показателями смертности от злокачественных новообразований легких, которые в группе работающих завода асбоцементных конструкции превышает аналогичные показатели среди городского населения (у мужчин – в 1,9 раза, у женщин – в 1,8 раза), что свидетельствует о достоверном влиянии условия труда в асбоцементном производстве на заболеваемость и смертность работников злокачественными новообразованиями легких.

Подтверждением канцерогенной опасности производства асбоцементных конструкции, наряду с показателями стандартизованного относительного риска развития злокачественных новообразований у работающих, явились также данные о том, что у онкологических больных основных цехов стаж работы в контакте с профессиональным фактором достоверно меньше в 2,5 раза, чем у работающих во вспомогательных цехах.

Таким образом, условия труда в Шымкентском производстве асбоцементных конструкции характеризуется повышенной канцерогенностью, что обусловлено высокой респираторностью асбестосодержащей производственной пыли, которая по концентрации в воздухе формовочного и аппаратного цехов от 2,15 до 2,7 раза превышают гигиенические нормативы.

Достоверно высокие уровни онкологической смертности от рака легкого наблюдается среди стажированных рабочих в возрасте 40-49 лет с нарастающим увеличением в каждой последующей возрастной и стажевой группе контингента.

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Зейнелова Л.Т., Сандыбаев М.Н., Челдыбаева Т.И.
Региональный онкологический диспансер г. Семей

Актуальность. Глава государства в своем Послании «Новое десятилетие - Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана» отметил, что здоровье народа - это неотъемлемая составляющая успеха Казахстана в достижении своих стратегических целей. В условиях экономических преобразований роль, функции и организационные формы деятельности сестринского персонала меняются в соответствии с новыми задачами, стоящими перед здравоохранением. В настоящее время в системе Министерства здравоохранения Республики Казахстан работают 119884 средних медицинских работников, что более чем в 2,4 раза больше врачей. Сегодня это соотношение врачебного и среднего медперсонала говорит о том, что в современной системе здравоохранения наряду с врачебной, эффективность оказания медицинской помощи зависит от применения модернизированной сестринской деятельности, направленной на повышение качества

оказания медицинской помощи, путем осуществления организационных сестринских технологий.

Управлять качеством сестринской помощи, по мнению Дороти Холл, можно лишь тогда, когда деятельность сестер изучена, структурирована, нормирована, а значит, может быть оценена в соответствии со стандартом.

Цель: Анализ качества работы среднего медицинского персонала на основе изучения анкет.

Материалы и методы: Всего за период с 2005-2009 гг. было изучено 2134 анкеты экспертных оценок сестринской помощи, 11971 анкета опроса пациентов о качестве оказываемой сестринской помощи.

На базе Регионального онкологического диспансера г. Семей работают 158 средних медицинских работников, из них 75% медсестер имеют квалификационную категорию, с высшим медицинским образованием 8 человек.

Для мониторингирования действий и результатов по принятой технологии сестринского процесса в лечебных отделениях стационара с 2005 года были внедрены «Карты сестринского наблюдения больных». Проведение анализа с использованием разработанных карт оценки сестринской деятельности улучшает качество медицинской специализированной помощи онкологическим больным, позволяет оценить качество работы структурных подразделений лечебно-профилактических учреждений. Предложенные механизмы внедрения в практику новых медицинских технологий обеспечивают проведение всесторонней и качественной оценки, учитывающей клинические, профессиональные и этические аспекты.

С целью изучения мнения пациентов об удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи проводится анкетирование пациентов по качеству ведения, культуре обслуживания, наличию информации по видам услуг, организации и качеству питания. Данные анализа результатов опроса оказывают несомненную роль в корректировке работы сестринской службы.

Результаты и выводы: Систематический анализ мнения больных показывает, что, начиная с 2005 года, удовлетворенность пациентов деятельностью среднего медицинского персонала в РОД г. Семей характеризуется ростом на 33,3%. При этом наиболее значительная положительная динамика наблюдалась в отделениях, имевших низкие показатели.

Таким образом, применение технологических карт оценки деятельности медицинских сестер способствовало повышению качества работы среднего медицинского персонала.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

*Коровников А.Г., Адылханов Т.А.,
Сандыбаев М.Н., Тулеутеев М.Е.*

*Региональный онкологический диспансер г. Семей,
Государственный медицинский университет г. Семей*

Актуальность: Прогресс в диагностике и терапии онкологических заболеваний поставил задачу сохранения качества жизни (КЖ) онкологических больных. Значительное снижение КЖ обусловлено как самим онкологическим заболеванием, так и специальным лечением, а также психогенными реакциями, встречающимися у всех больных.

Купирование пограничных психических расстройств у онкологических пациентов в настоящее время представляет значительные трудности, связанные с отсутствием в онкологических диспансерах системы психотерапевтической помощи.

В Региональном онкологическом диспансере (РОД) г. Семей с 2000 года введена штатная должность врача-психотерапевта. Работа врача-психотерапевта регламентируется Приказом № 147 МЗ РК от 31.03.1997 г. «О дальнейшем улучшении психотерапевтической помощи населению

Республики Казахстан».

Цель работы: Оценка эффективности работы врача-психотерапевта в учреждении онкологического профиля за период 2006 – 2009 гг.

Материалы и методы: В течение рассматриваемого периода врачом – психотерапевтом РОД было принято по рекомендации врачей-онкологов и самостоятельно 5912 больных, из них 1504 в диспансерном отделении, 4408 осмотрами в стационаре.

Психотерапевтическая помощь оказывалась на всех этапах лечения онкологических больных: на этапе диагностики, поступления в стационар, предоперационном, послеоперационном, этапе выписки из стационара, катamnестическом этапе и включала в себя индивидуальную, групповую и семейную мультимодальную психотерапию в сочетании с психотерапией. В зависимости от выраженности психологических нарушений, конкретных целей и запросов пациентов проводилось от 1-го (экспресс-психотерапия) до 15 сеансов.

Оценка эффективности психотерапевтических мероприятий проводилась клинически и по данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS.

Результаты: Субъективное и объективное улучшение психического состояния, снижение уровней тревоги и депрессии после проведенных психотерапевтических мероприятий отмечалось у 85 % получивших психотерапевтическую помощь онкологических больных.

Выводы: Таким образом, нами показано, что в большинстве случаев отмечен позитивный эффект проводимой врачом-психотерапевтом РОД коррекции пограничных психических расстройств у онкологических больных, что способствовало повышению КЖ пациентов. Полученные данные позволяют рекомендовать введение штатной должности врача-психотерапевта и организацию психотерапевтической службы в учреждениях онкологического профиля Республики Казахстан.

К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ.

*Сандыбаев М.Н., Суров М.Ю., Алдынгуров Д.К.,
Иванченко Е.В., Жунусов Г.А.*

Региональный онкологический диспансер г. Семей.

Актуальность проблемы: со второй половины XX века «реабилитация» является комплексом мероприятий, направленных на эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов в общество.

Почти 94%, стомированных пациентов – люди, прооперированные по поводу онкологических заболеваний. По данным Всемирной Организации здравоохранения число стомированных пациентов в каждой стране составляет примерно 0,05% – 0,1% от численности населения данной страны. Около 80% из них это люди преклонного возраста.

Материалы работы: по данным амбулаторного отделения Регионального онкологического диспансера г. Семей на «Д» учете с колостомами на начало 2010 года состоят 78 пациентов, из которых 52 (68%) человека жители города, 26 (32%) человека сельские жители.

Цель работы: улучшение качества жизни стомированных больных. Стомированный пациент зачастую не умеет правильно провести уход за стомой, сбалансировать питание, обслужить себя. О том чтобы вернуться к активной социально-трудовой жизни и речи не может идти. По вопросам социальной реабилитации обращаться чаще всего ему не куда. На сегодняшний момент в Казахстане нет литературы для стомированных людей, не налажена централизованная поставка средств индивидуального ухода. Пациентам приходится пользоваться моделями калоприемников устаревших морально. Средства высокого качества для большинства не

доступны.

Необходима служба реабилитации для данной категории людей. В развитых странах мира ассоциации стомированных больных существуют с конца 60-х годов. При правильно спланированном подходе большую часть людей можно адаптировать к новым условиям, вернуть на рабочее место и т.д.

Первым шагом к этому будет создание стома-кабинетов. В них люди получают исчерпывающую информацию по всем вопросам, начиная от питания и заканчивая вопросами семейной жизни. При возникновении сложных социально-трудовых вопросов могут привлекаться психолог, психотерапевт, специалист МСЭ. В наличии будет иметься литература по всем основным вопросам реабилитации и необходимое количество высококачественной продукции позволяющей пациентом чувствовать себя комфортно.

Выводы: Таким образом, возможно, значительно повысить качество жизни и добиться адаптации стомированного человека к новым условиям жизни.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОФОЛА И ТРАМАДОЛА ОНКОХИРУРГИИ.

Раев Г.Б.

*Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК,
Алматы.*

Одним из важных критериев в оценке анестезиологической защиты организма от хирургической агрессии является динамические показатели сердечно-сосудистой системы, в котором отражаются изменения нейровегетативного характера, обусловленные не только операционным стрессом, но и степенью ее антиноцицептивного эффекта.

Комплексное исследование центральной гемодинамики преследовало цель раскрыть патогенетические механизмы реакции кровообращения, наблюдаемые при хирургических операциях в условиях тотальной внутривенной анестезии (ТВА) и на основании изменений охарактеризовать степень адекватности каждого компонента обезболивания.

Были исследованы показатели центральной гемодинамики во время торакальных операций под ТВА у 42 онкохирургических больных в возрасте от 18 до 42 лет. По характеру оперативных вмешательств больные распределялись следующим образом пневмонэктомия-14, трансстернальная трансперикардальная окклюзия культи главного бронха-2, лобэктомия-10, сегментарная резекция – 27 больных. Премедикация была стандартной и включала пероральный прием седативных препаратов на ночь и внутримышечное введение за один час до операции реланиума, атропина, трамадола и нестероидных противовоспалительных препаратов в стандартных дозировках.

Индукцию осуществляли рекофолом $2,91 \pm 0,16$ мг/кг с одновременным введением трамадола $0,14 \pm 0,03$ мг/кг. Поддержание анестезии продолжали инфузией рекофола $3,03 \pm 0,16$ мг/кг/час и болюсным введением трамадола $0,11 \pm 0,03$ мг/кг/час. По ходу операции и наркоза изучали ударный объем крови, минутный объем крови, сердечный индекс, линейная скорость движения крови, мощность левого желудочка, расход энергии на передвижении крови, общее периферическое сосудистое сопротивление, конечное диастолическое давление в левом желудочке. Параметры центральной гемодинамики определялись методом реографии при помощи аппаратно-компьютерного комплекса «Рео-Спектр». У онкобольных несмотря на анемию, интоксикацию и гипопротинемию, средние значения всех гемодинамических показателей до операции соответствовали формальной «норме». У 27% больных зарегистрирован нормокинетический тип, у 48% гипокинетический тип, 23% гиперкинетический тип и 2% коллаптоидный тип кровообращения. Поэтому до 63%

у онкологических больных в предоперационном периоде нуждаются в коррекции функции сердечно-сосудистой системы.

Премедикация существенно не повлияла на показатели центральной гемодинамики. Индукционная доза трамадола вызывало кратковременное статистически недостоверное снижение УОК. УИ. Незначительно повышалось ОПСС, а болюсное введение рекофола уменьшало ОПСС, что приводило к снижению артериального давления на 15%. Течение анестезии на протяжении всего контролируемого периода характеризовалось стабильностью показателей центральной гемодинамики и отсутствием существенных изменений.

Вывод. Таким образом, онкологические операции при ТВА с использованием рекофола и трамадола у онкологических больных сопровождались стабильными показателями центральной гемодинамики.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Рахимжанова Р.И., Майер К.М.

*Национальный научный центр материнства и детства,
г. Астана РК*

Широкий научный и общественный интерес к проблеме рак молочной железы (РМЖ) обусловлен высокой заболеваемостью и смертностью от этого заболевания. Поэтому выявление причин этого явления призвано способствовать предотвращению этого ущерба. Профилактика РМЖ может быть эффективной только при комплексном рассмотрении факторов и условий, способствующих возникновению заболевания. Причиной роста заболеваемости РМЖ являются факторы, имеющих непосредственное отношение к той роли, которую выполняют молочные железы в организме женщин.

Факторы риска повышают шанс заболеть раком. Однако наличие фактора риска или даже нескольких факторов риска не означает, что возникнет рак. Риск может со РМЖ временем измениться за счет, например, изменения возраста или образа жизни.

Факторы риска развития РМЖ (Факторы риска рака и профилактика молочной железы (комплексная оценка) Я.Г. Райхман):

Первый фактор риска - наследственность по материнской линии, то есть наличие РМЖ у родственниц первой степени родства (матери, сестры, тети). Учеными был обнаружен ген, который определяет предрасположенность к РМЖ. Носители этого гена, по различным данным, передают его своим потомкам с вероятностью до 40%. Наличие РМЖ у кровных родственников 1-ой степени родства по материнской линии, увеличивает риск развития онкологических изменений в молочных железах в 4,5 раза.

Второй фактор риска - возраст. Риск возникновения РМЖ увеличивается с возрастом. Около 18% случаев РМЖ выявляется у женщин в возрасте 40-50 лет, в то время как 77% случаев рака диагностируется после 50 лет (Севостьянова О.С., 2006). Возникновению РМЖ способствуют также различные гормональные нарушения. Такие заболевания, как миома, эндометриоз, полипы, нарушение менструальной функции - все это факторы риска.

Больше вероятности заболеть у не рожавших женщин. Отсутствие послеродовой лактации и отказ от грудного вскармливания также может привести в дальнейшем к заболеваниям молочной железы. У женщин, имевших поздние первые роды (в возрасте более 30 лет) или не имевших родов, риск заболеть РМЖ в 2-3 раза выше, чем у рожавших до 20 лет. Каждые последующие роды в возрасте до 30 лет сопровождаются дальнейшим снижением риска. Риск заболеть РМЖ в возрасте до 40 лет в 5,3 раза выше у женщин, рожавших в возрасте >30 лет, чем у рожавших до 20 лет.

Ранние роды не оказывают защитного действия у женщин, имеющих мутации BRCA1 или BRCA2. Рожавшие женщины-носительницы мутаций BRCA1 или BRCA2 существенно чаще (в 1,71 раза) заболевают РМЖ в возрасте до 40 лет, чем не рожавшие. Каждая беременность у них ассоциируется с возрастом риска заболеть РМЖ в возрасте до 40 лет (Портной С.М., 2006).

Целью исследования явилось изучить факторы риска возникновения мастопатии у женщин с гинекологическими заболеваниями. Всего обследованы 2500 женщин, из них в основной группе 1250 больных с диффузной фиброзно-кистозной мастопатией на фоне гинекологической патологии и в контрольной группе 1250 пациенток с гинекологическими заболеваниями без патологии молочных желез. Выявлена прямая корреляционная связь патологии молочной железы с гинекологическими заболеваниями ($r=0,6$) такими как миома матки, гиперплазия эндометрия. Факторами риска развития диффузной фиброзно-кистозной мастопатией у женщин с гинекологическими заболеваниями являются: раннее менархе, альгодисменорея, снижение частоты рождаемости, прерывание первой беременности, выполнение больше трех медицинских аборт, отсутствие послеродовой лактации, наличие экстрагенитальных заболеваний - болезней органов пищеварения, кровообращения, эндокринной системы.

Таким образом, гинекологам необходимо особое внимание уделять на состояние молочных желез и проведение соответствующей патогенетически-обоснованной терапии, как гинекологических заболеваний, так и патологии молочных желез.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА В ОНКОЛОГИИ КАЗАХСТАНА

Тажединов И., Хан О.Г., Кайназаров Ч.

*Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы,
Республика Казахстан*

Качество и эффективность службы Ядерной медицины связаны с широтой и полноценностью ее внедрения в клиническую онкологию. Ядерная медицина состоит из разделов: Радионуклидная диагностика (in vivo), Радиоиммунные анализы (in vitro) и Радионуклидная терапия. В Республике применяются радионуклидные in vivo и in vitro методы исследования под общим названием Радионуклидная диагностика. Радионуклидная терапия в Республике используется эпизодически, в виде отдельных разработок.

В КазНИИОиР на двухдетекторной цифровой гамма-камере – однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) PHILIPS FORTE (2007г) проводится скintiграфия различных органов (печень, почки, кости скелета, щитовидная железа, сердце). Разработанные Институтом ядерной физики НЯЦ, прошли экспериментальные и клинические испытания радионуклиды: ^{99m}Tc , ^{131}I , ^{67}Ga , ^{201}Tl , меченые ^{99m}Tc -ДТПА и ^{131}I -гипуран, а также «Гель-генератора ^{99m}Tc ». Освоение технологии производства радиофармпрепаратов, особенно генератора ^{99m}Tc – событие государственной важности, является надежной предпосылкой для дальнейшего развития Ядерной медицины в Республике.

Высокоточный метод РИА также требует особого внимания. В КазНИИОиР проводят исследования по определению специфических опухолевых маркеров: СА 15-3 для опухолей молочных желез, СА 125 – рака гинекологической локализации, СА 19-9 – рака желудочно-кишечного тракта, ПСА – рака простаты и универсального раковоэмбрионального антигена РЭА.

Если развитие радионуклидной диагностики можно разделить на этапы – до и после появления генераторов короткоживущих радионуклидов (70-ые годы), то с новой эрой можно связывать появление ПЭТ-центров. Впервые в Казахстане Республиканском диагностическом центре г.

Астаны открылся ПЭТ-центр. Современный ПЭТ-центр сложный дорогостоящий комплекс, состоящий из медицинского циклотрона, радиохимической лаборатории и лаборатории радионуклидной диагностики с гамма- и ПЭТ-камерами, совмещенные с КТ. Из циклотронных радионуклидов исследования с ^{18}F , ^{11}C , ^{13}N и ^{15}O с $E_{\gamma}=511$ кэВ проводятся на ПЭТ-камерах, с ^{67}Ga , ^{201}Tl , ^{111}In , ^{123}I с E_{γ} от 93 до 173 кэВ – на гамма-камерах.

ПЭТ-центр административно должен находиться в составе отдела «Ядерной медицины» онкологической клиники, территориально в одном отсеке с единой вентилирующей системой и общим отстойником для жидких радиоактивных отходов, а также с общим хранилищем для твердых и мягких радиоактивных отходов. Штатные нормативы лаборатории радионуклидной диагностики с ПЭТ-центром должны включать кроме врача-радиолога по радионуклидной диагностике и терапии, радиохимика, инженера и дозиметриста.

На нынешних условиях не возможно привлечь новых сотрудников. Работа с повышенной радиоактивностью (жидкие открытые РФП) на сложных в эксплуатации современных гамма-камерах и ПЭТ-камерах. Необходимо увеличить надбавку на зарплату сотрудников за вредность и психоэмоциональную нагрузку, а также восстановить уход на льготную пенсию.

Радионуклидная терапия основана на применении метаболически активных радионуклидов и меченых соединений, избирательно накапливающихся и повреждающих в метаболической активной фазе клеточный механизм злокачественного роста. Для полноценного функционирования Ядерной медицины в Республике необходимо организовать центр радионуклидной терапии. Поскольку в ИЯФ производит выпуск ^{131}I , уже возможна радиойодотерапия больных раком щитовидной железы. В последующем можно организовать радионуклидную терапию больных с метастазами в костях.

НЕНАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК КАК КОМПОНЕНТ КОМБИНИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ

Танатаров С.З., Жакупов Р.К., Сандыбаев М.Н.,
Есболатов Д.А.

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Многокомпонентная анестезия обеспечивает полное и длительное выключение болевой чувствительности лишь при использовании последних в относительно высоких концентрациях, что вызывает нарушение гомеостаза и срыв адаптационных возможностей организма у больных с высоким анестезиологическим риском. Одним из направлений антиноцицептивной защиты стала предупреждающая анальгезия с применением средств системной и регионарной анестезии.

Цель исследования: Изучить анальгетическую эффективность парацетамола на фоне ингаляционной и эпидуральной анестезии.

Материал и методы исследования: Исследовано 35 пациента в возрасте от 43 до 75 лет, оперированных на органах желудочно-кишечного тракта. Объем выполненных операции в обеих группах были однотипными. В операционной на столе перед вводным наркозом вводили шприцевым насосом SEP-10S жидкий парацетамол в дозе 3,3 мг/ч. МВЛ проводили в режиме нормовентиляции с использованием *minimal flow anesthesia* (до 0,4 л/мин). Продленный эпидуральный блок на уровне Th4-6, осуществляли 10% раствором лидокаина. Центральная анальгезия парацетамолом в общей дозе 1 гр. Всем пациентам проводили мониторинг кардиомонитором Nikon Konden - FiO_2 ; ЭКГ с подсчетом ЧСС, АД, пульсоксиметрия; а также исследовали кислотно-основное состояние, К и Na плазмы крови.

Результаты исследования и их обсуждение: К началу основного этапа операции достоверно понизилось АДср,

однако это снижение не превышало в среднем 10% от исходного, что наряду с неизменными значениями общего периферического сосудистого сопротивления свидетельствовало о стабильности гемодинамики. Причины подобной стабильности АД – достоверный рост ударного объема в среднем на 20-30%. Относительное уменьшение ЧСС, отсутствие тахикардии снижает потребность миокарда в кислороде, что обеспечило более благоприятные условия функционирования сердечно-сосудистой системы при комбинированной анестезии. В нашем случае при использовании разработанной комбинированной анестезии ни в одном случае не наблюдалось гипертензии, а также не было выраженных гомеостатических сдвигов при комбинированной анестезии. Прочие показатели, характеризующие основные функции гомеостаза, не имели ухудшения относительно группы сравнения.

Вывод: Анестезия высокотравматичных операций продленным эпидуральным блоком в комбинации с ингаляционной анестезией и использованием парацетамола, обеспечивает значительную глубину анестезии, стабильность гемодинамики и гомеостаза при расширенных операциях в онкологии.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Танатаров С.З.

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Хирургические вмешательства в онкогинекологии являются главным этапом лечения большинства гинекологических больных. Однако расширение показаний к оперативному лечению и увеличение объема вмешательства были бы невозможными без углубленного изучения клинико-физиологических особенностей высокотравматичных и продолжительных операций с соответствующим развитием анестезиологии.

Цель исследования: Оптимизация анестезии внутривенным анестетиком пропофол в комбинации с ингаляционным анестетиком форан при онкогинекологических операциях.

Материалы и методы: Исследовано 37 наркозов, что соответствует и количеству пациентов (возраст от 25 до 65 лет) двух групп, оперированных в отделении маммогинекологии. Группы по полу, возрасту, росту, массе тела, классу ASA и продолжительности были сопоставимы.

После интубаций трахеи подключали ингаляцию форана в дозе 0,3-0,4 об.%. Центральная анальгезия поддерживалась введением субнаркозных доз фентанила. На основной наркоз рекофол вводили шприцевым насосом SEP - 10S в дозе 15-25 мл/ч с параллельной ингаляцией паров форана в дозе 0,3-0,5 об.% и кислорода, для поддержания хирургической стадий наркоза.

Интраоперационно изучали ЭКГ, ЧСС, АД, ЦВД, SpO_2 , FiO_2 , кислотно-основное состояние.

Результаты исследования: При комбинированной ингаляционно-внутривенной анестезии снижения АД мы не наблюдали. На этапах начала основного хода операции достоверно понизилось АДср в обеих группах, однако это снижение не превышало в среднем 5% от исходного, что наряду с неизменными значениями СИ и ОПСС свидетельствовало о стабильности гемодинамических показателей в обеих группах.

Преимущества комбинированной ингаляционно-внутривенной анестезии при онкогинекологических операциях отражены в следующем. При однотипном характере оперативных вмешательств, время восстановления сознания и экстубации трахеи составило в 1-й - 0,33 мин. $\pm 0,11$, а во 2-й группе 1 ч.30мин. $\pm 1,19$.

Выводы: Ингаляционно-внутривенный наркоз обеспечивает значительную глубину анестезии и достаточную стабильность регуляторных систем и гомеостаза при выполнении высокотравматичных онкогинекологических операций, что по-

звolyет уменьшить расход наркoтикoв в 15,3 раза, а фoрaнa в 1,36 раза, а тaкжe сoкрaщaя пepиoд пpoбуждeния пaциeнтoв в 2,5 раза, а вpeмя пoслeопepaциoннoй ИВЛ - в 1,5 раза.

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Лашкул С.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, г.Алматы

Фактор питания необходимо учитывать при выборе мер профилактики заболеваний различной этиологии, включая онкозаболевания.

Значительная роль в послеоперационном периоде онкобольных отводится продуктам зондового, парентерального и перорального питания. Учитывая основные этиопатогенетические механизмы, лежащие в основе развития онкопатологий был разработан специализированный продукт для послеоперационных больных на соевой основе, богатый полноценным легкодоступным белком, полиненасыщенными жирными кислотами, моно- и дисахаридами, а также витаминами- антиоксидантами и микроэлементами.

Продукт создан на основе соевого молока, сброженного специальными штаммами молочнокислых бактерий с высокой биохимической активностью, с добавлением соевого творога, соевого масла, облепихового и/или шиповникового сиропа, сиропа черной смородины, яблочного пюре, витаминов А, Е, С, фолиевой кислоты, микроэлементов железа, селена, цинка. Назначение специализированного продукта «Унипит-КАП» с целью лечения послеоперационных онкологических больных в мировой практике неизвестно. Соевое молоко и соевый творог, как известно, богаты полноценным, легкодоступным белком, а также низкомолекулярными пептидами. Продукт содержит соевое масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, а также витаминами А и Е.

Наличие специальных штаммов молочнокислых бактерий с высокой биохимической активностью препятствует развитию дисбактериоза, возникающего в результате длительного воздействия антибиотиков широкого спектра действия и химиотерапии в период лечения.

Продукт «УнипитКАП» обладает антиоксидантными, иммунокоррегирующими, детоксицирующими и микробиоценоз-нормализующими свойствами.

Основными принципами конструирования спецпродукта для онкобольных были:

- 1) высокая пищевая и биологическая ценность исходного сырья;
- 2) повышенный уровень легкодоступных протеинов, жиров и углеводов;
- 3) антиоксидантная направленность в подборе как сырья, так и пищевых добавок;
- 4) иммуномодулирующая направленность в выборе сырья;
- 5) присутствие микробиоценоз-нормализующих факторов;

Рецептура продукта и технология приготовления продукта проста, удобна с экономической точки зрения. Действие специализированного продукта направлено на повышение защитных сил организма, снижение процессов перекисного окисления липидов, активацию монооксигеназной системы, улучшению функциональной активности желудочно-кишечного тракта, уменьшению токсемии.

Основными принципами или условиями применения продукта «УнипитКАП» в комплексной терапии онкобольных были:

- профилактика дисбактериоза кишечника, нормализация функции желудочно-кишечного тракта в случае возникновения желудочно-кишечного кровотечения;
- снижение всасывания токсических продуктов рас-

пада;

- снижение свободнорадикального окисления липидов;

- активация иммунологической реактивности и гемопозитической функции организма.

Учитывая вышеизложенное, надо полагать, что лечение онкологических больных с включением специализированного диетического продукта «УнипитКАП» с иммуностимулирующими, детоксицирующими и антиоксидантными свойствами следует отнести к способам патогенетического лечения онкологических заболеваний, поскольку процессы перекисного окисления липидов и нарушение иммунологической реактивности являются одними из ведущих патогенетических механизмов после химио-и лучевой терапии онкологических больных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГАДОВИСТ» И «МАГНЕВИСТ» В ДИАГНОСТИКЕ ФИБРОАДЕНОМ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Рахимжанова Р.И., Садуакасова А.Б., Байтурлин Ж.Г.

АО Медицинский университет Астаны

Широкое внедрение магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастным усилением в отечественной медицине сдерживается недостаточной доступностью МРТ-аппаратов и слабой осведомленностью специалистов о высокой диагностической эффективности этого метода.

МРТ молочной железы осуществлялась на МРТ SIEMENS SYMPHONY с резистивным магнитом 3,0 Тл. Для сравнения эффективности МР контрастных веществ (МРКС) 12 женщинам, при их информированном согласии, был введен «Магневист» при первичной диагностике, повторная МР-маммография с введением нового МРКС «Гадовист» (Schering, Германия) проведена через 5 дней в первой фазе менструального цикла.

Диагностика фиброаденомы базируется только на семиотике доброкачественного процесса. Из характерных для МРТ-симптомов следует назвать присущую фиброаденоме и локальному фиброзу изоинтенсивность и однородность гипоинтенсивного сигнала от образования в протоколах T1 и T2ВИ. На T1ВИ фиброаденома имеет гипоинтенсивный сигнал, на T2ВИ сигнал от образования повышенный. Чем больше относительная доля фиброзной ткани, тем ниже сигнал от фиброаденомы. При МРТ до применения пост-процессорной обработки мы получали информацию, позволяющую оценить образование не менее чем по 9 критериям, свидетельствующие в пользу доброкачественной природы образования. Однако, указанные МР-признаки не применимы для всех образований доброкачественной природы, т.к. они не являются единственно возможными для злокачественных образований. Поэтому необходима дополнительная информация, которую мы получали при наблюдении за скоростью нарастания интенсивности МР-сигнала (накопление контрастного вещества) на T1 ВИ и скорости ее снижения (вымывания). Чувствительность МР-маммографии с контрастным усилением при введении Гадовиста больше, чем при использовании МРКС первого поколения («Магневист») за счёт большего релаксационного воздействия. Сравнение двух парамагнитных контрастных средств «Магневист» и «Гадовист» в диагностике фиброаденом установлено, что при времени достижения максимума у двух МРКС от 3 до 5 мин, фаза вымывания «Магневиста» выявлялась к 6-7 минуте, а на кривой изменения интенсивности сигнала от опухоли после введения «Гадовиста» формировалось «плато» с тенденцией к появлению незначительного уменьшения МР-сигнала только к 11-15 минуте.

Таким образом, при исследовании молочных желез показано применение «Гадовист» в виду его большей специфичности.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Тулеутаев М.Е., Оразбеков Б.С., Муслим М.М., Жумагазин Ж.Д., Медеубаев Р.К.

Онкологический диспансер г. Астана

Введение: Хронический пиелонефрит (ХП) и вторичный цистит часто осложняют рак мочевого пузыря (РМП) и иногда являются причиной летальных исходов при этих заболеваниях. Поэтому предупреждение и рациональное лечение пиелонефрита и вторичного цистита у больных РМП является весьма актуальной проблемой до проведения специального лечения.

Цель работы: Изучить влияние инфекционно-воспалительных осложнений на течение РМП.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 36 больных РМП, которым было выполнено комплексное обследование и оперативное лечение в онкологическом диспансере города Астаны с 2003 по 2009 г. В основном больные поступали в плановом порядке, только 3 (5,3%) из них были госпитализированы по экстренным показаниям. Основными показаниями для экстренной госпитализации явились: макрогематурия, невозможность самостоятельного мочеиспускания в связи с тампонадой мочевого пузыря (МП) сгустками крови и обострение ХП. Мужчин было 29 (80,6%) и женщин - 7 (19,4%). Возрастной диапазон колебался от 35 до 73 лет и в среднем составил $57,5 \pm 1,3$ года. Симптомы инфравезикальной обструкции наблюдались у 9 мужчин: у двоих с дивертикулезом МП, у одного со стриктурой уретры и у остальных 6 она была вызвана доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Результаты: Подавляющее большинство больных 34 (94,4%) поступили в клинику с инвазивной формой РМП, поэтому многие из них были отягощены его осложнениями. Вторичный цистит был у 27 (75,0 %) больных. Одностороннее нарушение уродинамики верхних мочевыводящих путей имело место у 15 (41,6%) пациентов, двусторонний гидроуретеронефроз у 3 (8,3%). С обострением ХП в клинику поступил 14 (38,8%) пациентов. Хроническая почечная недостаточность 1-2 стадии выявлена у 9 (25,0%) больных РМП, анемия легкой и средней степени тяжести у 12 (33,4%) пациентов.

В дооперационном периоде у 19 (52,8%), больных, несмотря на проводимую антибактериальную терапию, регистрировали бактериурию. Данные о характере микрофлоры мочи, высеянной у них, приведены в таблице 1.

Вид микроорганизмов	Количество больных	
	абс.	%
<i>Escherichia coli</i>	7	36,8
<i>Enterobacter spp.</i>	5	26,4
<i>Enterococcus faecalis</i>	4	21,0
Прочие	3	15,8

Заключение: Инфекционно-воспалительные осложнения часто встречаются у больных РМП. Это обусловлено общим снижением иммунитета при онкологическом процессе, нарушением архитектоники стенки мочевого пузыря, и как следствие, нарушение микроциркуляции с распространением неопластического процесса на устья мочеточников с развитием ретенционных изменений в верхних мочевыводящих путях (ВМП), как правило, сопровождающихся обструктивным пиелонефритом. Поэтому, большое значение приобретает дооперационное дренирование ВМП при наличии гидроуретеронефроза и проведение этиопатогенетического лечения инфекционно-воспалительных осложнений, что, безусловно, улучшает показатели послеоперационной выживаемости у данной категории больных.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Исмаилова Г.Н., Зейтын М.К.,
Ермаханова Г.А., Абдрахманов А.Б.

КазНИИОР, Институт развития здравоохранения МЗ РК

Концептуальная переменная имеет определенные значения, которые в совокупности исчерпывают диапазон возможных изменений. Количество значений переменной практически бесконечно.

Нами проведен социологический опрос населения в 6 регионах Казахстана по изучению мнения изучаемой популяции о культуре безопасности пациентов в медицинских организациях. На основе данного анкетирования сформированы следующие концептуальные переменные: степень информированности пациента; степень ответственности самого пациента; степень удовлетворенности пациента условиями пребывания в медицинской организации. В качестве шкалы измерения использовалась анкета (опросник).

Шкала измерения для концепции «Степень информированности пациента» состояла из вопросов об информировании врачом пациента о состоянии его здоровья, о возможных методах диагностики и лечения, прогнозирования возможных осложнений; о форме получения согласия пациента на проведение мероприятий; о соблюдении пациентом рекомендаций врача; об информировании врачом о правилах приема лекарственных средств и их совместимости; о проведении инструктажа при получении физиотерапевтических процедур; об информировании о мерах предосторожности после инъекций и др.

Шкала измерения для концепции «Степень ответственности самого пациента» включала вопросы о соблюдении пациентом рекомендаций лечащего врача, о приеме лекарств пациентом, не рекомендованных лечащим врачом, об изучении вкладыша (инструкции) лекарственного средства, об информировании пациентом врача о любых аллергических и побочных эффектах от лекарств.

Вопросы, касающиеся создания условий в медицинских организациях для соблюдения личной гигиены; отношении медицинского персонала к пациенту; случаях получения травм в пределах медицинского учреждения объединены в концепцию «Степень удовлетворенности пациента условиями пребывания в медицинской организации».

На основе шкалы измеряемой концепции разработана операциональная определяющая в бальной системе. Например, на вопрос об информированности врачом о состоянии здоровья пациента, методах диагностики и лечения ответу «да, в полном объеме» соответствует 2 балла, это максимальный балл, ответам «да, но не в полном объеме» и «не всегда» - 1 балл, а категорично отрицательные ответы, такие как «нет», «никогда», «не получал» равны 0 баллов.

Оценка степени информированности проводилась следующим образом. Полная информированность пациента составляет 8 баллов и более, средняя информированность - 4-7 баллов, низкая информированность - 0-3 балла.

По такому же принципу распределены баллы по ответам на вопросы, сгруппированные в концепции «степень ответственности самого пациента» оценивалась по совокупности баллов - 10 баллов и более оценивается как высоко ответственный; от 5 до 9 баллов - недостаточно ответственный; безответственное отношение пациента к своему здоровью - 0-4 балла.

Аналогично распределение баллов и по степени удовлетворенности пациента условиями пребывания в медицинской организации. При сумме баллов 5 баллов и выше оценивается как удовлетворительная степень; неудовлетворительная - 0-4 балла.

Таким образом, формирование концептуальных переменных создает методическую основу для оценки уровня

культуры безопасности среди пациентов в медицинских организациях.

ИНДОЛ-3 КАРБИНОЛ В ЛЕЧЕНИИ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тлеугабилова Г.А., Кожамбетов Б.Ш., Абдулаханова Р.Р.,
Есентаева С.Е.

Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей

Актуальность. За последние годы увеличилось число пациенток, обращающихся в различные лечебные учреждения по поводу дисгормональных нарушений молочной железы и доброкачественных опухолей молочной железы. Самым распространенным среди них является мастопатия, встречающаяся у 20-40% женщин в возрасте от 20 до 50 лет.

Индол-3 карбинол – вещество, обладающее способностью к множественной фармакологической коррекции молекулярно-биологических процессов.

Цель работы. Улучшение методов лечения дисгормональных нарушений молочной железы

Материалы и методы. Комплексно обследовано более 270 женщин. Обследование включало клинический осмотр, маммографию (МГ), ультразвуковое исследование (УЗИ), осмотр гинеколога, консультацию эндокринолога. Выделены группы больных (N=88) в возрасте от 22 до 56 лет со следующими нозологическими формами:

- выраженная фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) с преобладанием кистозного компонента -26 (29,5 %);
- выраженная ФКМ с преобладанием фиброзного компонента – 28 (31,8 %)
- диффузная мастопатия (ДМ) с преобладанием железистого компонента (аденоз) – 6 (6,8 %)
- формирующаяся фибroadенома – 28 (31,8 %).

75 (85,2%) больных предъявляли жалобы на боли (масталгии) в молочных железах. Уплотнение в молочных железах пальпировалось у 24 (27,3%), сопутствующая патология была выявлена у 13 (14,8%). Сопутствующие заболевания включали миому матки – 6 (6,8%), тиреоидит- 10 (11,4%), узловой зоб – 12 (13,6 %).

В 8% случаев при подозрении на рак проводилась пункционная биопсия с цитологическим исследованием. Больным с сопутствующими заболеваниями проводилось дообследование, включающее анализ крови на гормоны (ТТГ, Т3, Т4, ЛТГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон и пролактин), УЗИ щитовидной железы, яичников, гинекологическое обследование. У 7,4% пациенток было повышенное содержание эстрогена в крови, 2,7% - повышение уровня Т4 гормона щитовидной железы.

Результаты и выводы. Индол-3 карбинол назначался всем больным с мастопатией, фибroadенозом, формирующейся фибroadеномой в течении 3-6 месяцев с динамическим контролем.

Через 3 месяца пациентам был проведен контроль, включающий клинический осмотр, МГ (женщинам старше 35 лет), УЗИ (до 35 лет) и дообследование больным с сопутствующей патологией (анализ крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы, яичников, гинекологический осмотр).

После 3-х месячного курса лечения в ходе комплексного обследования получены следующие результаты. У всех больных ФКМ, ДМ, формирующей фибroadеномой было отмечено субъективно – уменьшение боли (масталгия), нормализация менструального цикла. Объективно – уменьшение плотности ткани и отека на МГ, уменьшение или полное рассасывание формирующихся аденом по данным УЗИ. Побочные эффекты не наблюдались.

Таким образом, индол-3 карбинол является эффективным

и безопасным средством для нормализации гормонального баланса при различных формах мастопатий, формирующихся фибroadеном. Эффект лечения от применения препарата достигает от 3 до 6 месяцев, что зависит от формы мастопатии и от размера формирующихся фибroadеном, также связано с глубинными механизмами воздействия на регуляцию гормонально- метаболических процессов в организме.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСERA Г.СЕМЕЙ.

Бекетова Б.Б., Кузнецова Т.В.,

Кротова А.Г., Хамитова Д.А.

Региональный онкологический диспансер г.Семей

Актуальность. Внедрение в практическое здравоохранение эффективной скрининговой диагностики рака молочной железы (РМЖ) – один из возможных путей улучшения результатов этой патологии. Экономическая эффективность скрининга определяется снижением смертности и уменьшением общих затрат на лечение.

Цель работы: Изучить эффективность маммографического скрининга по данным регионального онкологического диспансера

Материал и методы: С 2008 года в региональном онкологическом диспансере г.Семей начато проведение маммографического скринингового обследования женщин в возрастной группе от 50 до 60 лет с интервалом проведения маммографии 1 раз в 2 года. Данное обследование производится на основании приказа МЗ РК от 15.10.2007 № 607. Обследование осуществляется на маммографах: «Alpha ST» (Финляндия, 2006 год) и «Melody B» (Италия, 2004 год). Исследование у менструирующих женщин выполняется с 5-го по 12-й день менструального цикла.

В ходе скрининга маммографическому исследованию за 2008 -2009 годы были подвергнуты 8608 (80,3%) женщин из запланированных 10711. Патологии молочных желез не обнаружено у 4947 (57,5%) женщин. Им рекомендовано самообследование и регулярный осмотр молочных желез с профилактической целью в медицинских учреждениях и повторная маммография через 2 года. Патологические образования в ткани молочной железы выявлены у 3661 (42,5%) женщин. У 2531 (69,1%) пациенток эти образования имели диффузный невыраженный характер, им не требовалось дообследование и рекомендовано диспансерное наблюдение у маммолога. Для уточнения характера патологического процесса в дополнительном обследовании нуждались 1130 (30,9%) женщин. В онкодиспансер для дальнейшего обследования обратилось 854 (75,5%) женщин.

Результаты и выводы: При дополнительном исследовании диффузные изменения отмечены у 591 (69,2%). Чаще всего они были представлены диффузной фиброзно-кистозной мастопатией. Узловые образования диагностированы у 263 (30,8%) пациенток, из них фибroadеномы у 165, узловые мастопатии у 98. Секторальная резекция молочной железы выполнена 128 (48,7%) женщин, при которой данных подтверждающих злокачественный процесс не получено. Подозрение на рак молочной железы на основании маммографического исследования выставлен у 82(0,9%) женщин, из них у 29 (0,3%) женщин диагноз был подтвержден морфологически.

В Казахстане маммографический скрининг данной возрастной категории женщин идет 2 года и конечно делать выводы еще рано, однако уже сейчас видно, что выявляемость ранних стадий рака молочной железы стало больше.

Таким образом, проведение маммографического скрининга, несомненно, является неотъемлемым мероприятием в борьбе с раком молочной железы.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЕКСАНА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Бектурсынов С.М.

Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган

Цель работы: Является улучшение микроциркулярной крови, а также улучшение ближайших и отдаленных результатов лечения РМЖ путем предупреждения макро и микротромботических осложнений в процессе комбинированного лечения.

Материалы и методы: Обоснованного проведения в раннем послеоперационном периоде антитромботической терапии с целью снижения частоты тромбоэмболических осложнений и одновременно такая терапия может иметь противорецидивный и антиметастатический характер. Наблюдались 125 больных, которым проведена в раннем послеоперационном периоде антитромботическая терапия клексан при РМЖ с II-III A стадией заболевания (I группа). Контролем служила группа больных РМЖ у 20 лиц

Результаты лечения: Общая пятилетняя выживаемость 81,0 %. В показателях свертывающей и противосвертывающей системы крови наибольшие динамические различия наблюдаются на 7 сутки послеоперационного периода: - снижается тромбиновое время (сек.):

- тромбиновое время - 40,1, 35,6, 31,1 (сек) соответственно. Возрастает содержание свободного гепарина - 6,7, 7,1, 7,9 и - фибринолитическая активность (%) - 20,1, 20,5, 26,7 соответственно

Выводы: Применение антикоагулянта клексана в послеоперационном периоде снижает активность коагулирующего потенциала крови и послеоперационная химиоантикоагулянтная терапия приводит к улучшению показателей выживаемости.

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ.

Тулеутеев М.Е., Оразбеков Б.С., Жанабекова Ж.Ж.

Онкологический диспансер г.Астана

Введение: У большинства женщин после установления диагноза развивается тяжелый психологический стресс: здесь и страх перед калечащей операцией (удаление груди), и необходимость пройти через трудное лечение и непереносимость нового знания о себе как онкологической больной. Бывает и так, что перед выбором делать операцию (удалять грудь) или не делать (оставлять опухоль и жить с ней) некоторые женщины могут сделать выбор в пользу последнего, так как боятся потерять женскую привлекательность, сексуальность, а значит, есть вероятность распада семьи, если она была, или невозможность создать ее. На этом фоне после удаления груди многие женщины испытывают чувство неполноценности, ущербности, тревожные состояния, которые могут доходить до депрессии. Профилактика подобных состояний, включающая оказание своевременной психологической помощи до операции и психологическое сопровождение после мастэктомии, является актуальной проблемой в лечении женщин с раком молочной железы.

Цель работы: выявить состояние тревожности и депрессии, обусловленные удалением молочной железы.

Материалы и методы: было опрошено 56 женщин от 30 до 60 лет средний возраст которых составил $47 \pm 2,3$ лет, перенесших операцию по удалению груди, проходящих комбинированное или комплексное лечение в онкологическом диспансере г.Астаны по экспресс-методике «Тид» (тревожность и депрессия) для оценки психического состояния женщин.

Результаты: большинство женщин 42 (75%) по итогам диагностики набрали алгебраическую сумму коэффициентов,

свидетельствующей о выраженной психической напряженности, тревожности, депрессии. Ее пограничные значения характеризуют 9 (16%) женщин. Промежуточные значения (говорящие о неопределенности данных) имели 5 (9%) пациенток. Никто из тестируемых женщин (0%) не набрал сумму коэффициентов, свидетельствующую о хорошем психическом состоянии.

Закключение: таким образом, многие женщины после радикальной мастэктомии находятся в состоянии тревожности и депрессии, проявляющихся в ослаблении тонуса жизни и энергии, в снижении фона настроения, сужении и ограничении контактов с окружающими, наличии чувства безрадостности и одиночества. Поэтому так важна реабилитация женщины после оперативного вмешательства. Нужно поддержать и уверить ее, что это не конец жизни, а один из ее новых этапов. Конечно, при этом качество жизни меняется, нужно привыкать к новому телу, к новому образу жизни. Большое значение здесь имеет поддержка мужа, семьи, друзей, принимающих ее такой, какая она есть, групп поддержки (пациентов со сходным диагнозом).

ПЕРВИЧНОЕ ДВОЙНОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Чорманова Р.Р., Харламов В.В.,

Жунусова А.Ж., Садыков М.С.

РГП ЦКБ УД ПРК г.Алматы

Рост заболеваний толстой кишки у лиц пожилого и старческого возраста, омоложение колоректального рака, требует совершенствования диагностических методик

В этой связи особенно актуальна предложенная в 1961г. Wellin методика рентгенологического исследования толстой кишки, названная автором одномоментным двойным контрастированием. Внедрение в практику фиброколоноскопии значительно расширило возможности диагностики заболеваний толстой кишки. Однако, сужения просвета кишки опухолью, резкие изгибы в некоторых отделах и другие факторы ограничивают возможность эндоскопического метода в изучении состояния ободочной кишки на всем ее протяжении. При локализации опухоли в правой половине толстой кишки провести фиброколоноскоп до участка поражения удастся не всегда.

В то же время наличие сопутствующих заболеваний, снижение функциональных и компенсаторных возможностей у пациентов ограничивают возможности рентгенологического метода исследования толстой кишки. У пожилых ослабленных больных ирригоскопию по общепринятой 3-х фазной методике (тугое заполнение, опорожнение, раздувание) выполнить зачастую затруднительно. Выбор вида оперативного лечения зависит от точных представлений о местной распространенности процесса, состояния других отделов толстой кишки, характере роста опухоли и других факторов.

Материалы и методы исследования

Усовершенствование методики ирригоскопии с первичным двойным контрастированием предполагает разработку устройства для выполнения ирригоскопии по усовершенствованной методике.

Техническое устройство для выполнения ирригоскопии состоит из аппарата Боброва емкостью 1 литр и дополнительного сосуда для эвакуации избыточной взвеси. Емкость с бариевой взвесью находится в горизонтальном положении в узкой коробке. При положении отогнутой трубки «вниз» (при погружении ее в контрастное вещество) нагнетается бариевая взвесь, при положении загнутой трубки «вверх» (конец трубки находится над уровнем контрастного вещества) нагнетается воздух.

Аппарат Боброва соединен с сосудом для эвакуации избыточной взвеси. и одноразовым наконечником эластичными резиновыми шлангами через тройник. Во время исследования сосуд для эвакуации взвеси бария находится ниже трохо-

скопа. Для прекращения продвижения взвеси или воздуха используются зажимы.

Рентгенологическое исследование толстой кишки по усовершенствованной методике проводилось нами в условиях стационара и поликлиники. Особенности методики являются порционное попеременное введение бариевой взвеси и воздуха. Введение вышеперечисленных контрастных сред чередуется в процессе исследования с периодической их эвакуацией. Подготовка толстого кишечника к исследованию осуществляется в два этапа: вечером в 21 час выполняется две очистительные клизмы теплой водой (1-1,5 литра) с интервалом в один час. Утром за два часа до исследования выполняется так же две клизмы в выше обозначенном режиме.

После введения наконечника, в положении больного на левом боку, снимается зажим со шланга от нагнетающего устройства. Под минимальным давлением вводят 100-150 мл бариевой взвеси и воздуха до заполнения прямой кишки. И дистального сегмента сигмовидной кишки. Производится рентгенография указанных отделов в прямой, косых, боковой проекциях в условиях дозированного заполнения, частичного опорожнения и двойном контрастировании. Затем попеременно вводится бариевая взвесь и воздух до заполнения всех отделов толстой кишки под контролем просвечивания. При равномерном контрастировании всех отделов толстой кишки больного поворачивают на правый бок и выполняют снимок в латеропозиции на пленке 30×40, затем эвакуируют контрастное вещество из прямой кишки в сосуд для сбора избыточного контраста и вынимают наконечник. Больного поворачивают на левый бок и выполняют второй снимок в латеропозиции. Третью рентгенограмму выполняют в вертикальном положении больного у стойки. На этом исследование заканчивается и больной идет в туалет. После проявления рентгенограмм при необходимости выполняются прицельные и обзорные снимки. Время просвечивания занимает не более 2-х минут, все исследование занимает не более 10 минут. На одно исследование необходимо до 400 мл бариевой взвеси.

Нами выполнено 25 исследований методом первичного двойного контрастирования. Были обследованы пациенты в возрасте от 25 до 80 лет и старше. Преобладали пациенты старше 70 лет. В возрастной группе от 25 до 47 лет у 4 пациентов патологических изменений со стороны толстого кишечника выявлено не было. Дивертикулы сигмовидной кишки выявлены у 4 пациентов. Удлинение сигмовидной кишки у 3 пациентов. Баугинит – 2 пациента. Полип нисходящего отдела толстой кишки – 1 пациент. У 10 пациентов дискинезия левых отделов, колит. Рак ректосигмоидного отдела – 1 пациентка.

Результаты. Таким образом, разработка новых и совершенствование известных рентгенологических методик ирригоскопии, к которым относится методика первичного двойного контрастирования, с целью повышения информативности, облегчения переносимости процедуры пожилым и ослабленным больным, является весьма актуальной. Основным достоинством предложенной методики является сочетание «тугого» наполнения и двойного контрастирования, позволяющего фиксировать внутрисстеночную инфильтрацию кишки в ее начальных проявлениях с помощью определения состояния контура кишки и толщины стенки. Двойное контрастирование позволяет получить исчерпывающую информацию о слизистой кишки, которая при отсутствии в ней изменений (небольших полиповидных образований, изъязвлений) должна быть полностью разглажена и лишена складчатости. При эндофитном росте опухоли в просвет кишки совершенно отчетливо визуализируется дополнительная тень. Отчетливо видны ее контуры. При внутрисстеночном поражении опухолью дифференцируется сужение просвета кишки и соответственно этому неровность контура на небольшом протяжении. При двойном контрастировании на

этом уровне выявляется утолщение стенки. При наличии изъязвления в инфильтративно измененном участке стенки, отчетливо дифференцируется «краевой дефект».

Основная цель предложенной методики состоит в улучшении рентгенологической диагностики рака прямой и ободочной кишки.

На основе рентгеноанатомических сопоставлений открывается возможность визуализации рентгенологических признаков заболеваний толстой кишки, выделение рентгенологических симптомокомплексов, косвенно свидетельствующих о состоянии стенки кишки. Открывается возможность высокой информативности усовершенствованной методики ирригоскопии в изучении состояния всех отделов толстой кишки. Применение предложенной усовершенствованной методики позволяет экономить материальные средства (контрастное вещество), сокращает время исследования, снижает лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал.

Выводы. Усовершенствованная методика рентгенологического исследования толстой кишки проста в исполнении, легко переносится больными и может с успехом применяться как в стационаре, так и в поликлинических условиях.

Одномоментное двойное контрастирование – один из оптимальных методов традиционной рентгенологии в диагностике ее опухолевых поражений.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ

Шелякина Т.В., Гагагажеева З.М.,

Канторова А.А., Евлаева М.И.

РНИОИ г. Ростова-на-Дону, Ингушский РОД

Актуальность: Онкогинекологическая патология характеризуется опасной тенденцией – ростом заболеваемости раком молочной железы (РМЖ), яичников (РЯ), шейки (РШМ) и тела матки (РТМ), у женщин моложе 50-ти лет, причем треть больных на этапе морфологической верификации имеет распространенные формы.

Общепринятые профосмотры дают низкую выявляемость, а наиболее важный фактор в лечении данного рака – своевременная диагностика.

Цель работы: Разработка наиболее эффективных организационных форм для скрининга рака репродуктивных органов.

Материалы и методы: Ретроспективное эпидемиологическое исследование в группе больных РШМ, РТМ, РЯ, РМЖ и здоровых лиц, социальные (анкетирование), организационные (Открытый прием (ОП) женского населения), клинические (дообследование), математико-статистические.

Результаты: На основе полученного информационного веса каждого признака (с помощью χ^2) установлены факторы онкологического риска (для каждой локализации и общие). Разработаны диагностические карты для каждой локализации и внедрены на ОП в Ингушском РОД.

При обследовании 332 женщин – 250 (78%) были включены в группы онкологического риска. Изучена мотивация обращения женщин на ОП. Основным ориентиром в формировании этих групп явились карты диагностических коэффициентов.

В целом выявлено 17 случаев рака: 4 - РШМ (II-III st. – 2; III-IV st. – 2, 2 - suspicio), 6 - РТМ (II st. – 2; II-III st. – 2; III-IV st. – 2 и 3 - suspicio), 3 - РЯ, 4 - РМЖ (II st. – 2), составляя: 7,0% к группе риска и 5,0% ко всем женщинам, обратившимся на ОП. В целом был выявлен рак у 10 пациенток - II-III st, 7 - III-IV st.

Также выявлено 63 случая доброкачественных опухолей, которые ранее не подвергались лечению (30% к группе риска и 21,6% к женщинам, обратившимся на ОП), и 120 случаев с хроническими воспалительными заболеваниями.

Выводы: Организация ОП населения позволила женщинам беспрепятственно обращаться к высококвалифицированному специалисту, а диагностические карты - более организованно и точно определить женщин, которым необходимо дальнейшее наблюдение и обследование в онкодиспансере.

ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ РЕНТГЕН СНИМКОВ

*Чорманова Р.Р., Харламов В.В.,
Садыков М.С., Жунусова А.Ж.
ЦКБ УДП РК, г. Алматы*

Цель работы: Получение высококачественных рентгенологических изображений в цифровом виде, компьютерной обработкой с классических рентгеновских аппаратов.

Материалы и методы: Обследования проводились на аппаратах SIEMENS R100, «Полиомобиль плюс» и цифровой приставке CR-30X, с различными локализациями, в различных положениях и проекциях.

За короткий промежуток времени было проведено 558 исследований на цифровой приставке, при этом рентгенография органов грудной клетки - составила 105 исследований, рентгеноскопия желудка - 71, рентгенография костей - 262, мочевого выделительной системы - 66 (обзорная и экскреторная урография, восходящая цистография) и прочие - 54 исследования. К прочим исследованиям мы отнесли такие исследования, как придаточные пазухи носа, метросальпингография и фистулография.

Результаты: Цифровое рентгеновское изображение позволяет рентгенологам проводить более точную и детальную дифференциальную диагностику заболеваний, например, один снимок органов грудной клетки позволяет увидеть почти все ткани разной плотности: от мягких тканей до костной структуры. При этом возможно увеличивать отдельные интересующие участки рентген снимка (зона интереса), вносить надписи и комментарии, делать всевозможные замеры, расстояния, углы. Резко снижается расход рентгеновской пленки. Обработанные снимки хранятся в цифровом виде и при необходимости могут быть распечатаны. Цифровые рентгенограммы могут пересылаться по сети в архив, другое отделение, другую больницу и по Интернету, а так же записаны на любой цифровой носитель.

CR – система, устанавливается в любом амбулаторном и стационарном рентгенологическом кабинете, где она может оцифровать любой снимок сделанный с любого имеющегося аналогового рентген аппарата, палатного и переносного. При этом для установки CR – системы не требуются дополнительные изменения уже работающих рентгеновских аппаратов, столов и помещений, более того, внедрения этого комплекса позволяет полностью отказаться от темной комнаты и мокрой проявки. Тем самым улучшая условия работы среднего медицинского персонала.

Выводы: Цифровая обработка рентген-снимка незаменима в условиях поликлиники, реанимации и неотложной скорой помощи, так как многократно уменьшается время, затраченное на получение готового изображения и нет бракованных снимков связанных с неправильным выбором режима съемки.

Современные технологии с математическим модулированием рентген снимка уменьшают лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал.

Изменение яркости, контрастности, размеров теней в негативном и позитивном рентген изображении улучшают качество снимка, увеличивают диагностические возможности, облегчают интерпретацию рентген-снимков, что повышает эффективность лечения.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

*Харламов В.В., Чорманова Р.Р.,
Жунусова А.Ж., Садыков М.С.
РГП ЦКБ УД ПРК г.Алматы*

Опухоли тонкой кишки встречаются с одинаковой частотой как у мужчин, так и у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Встречаются достаточно редко – 1,364% (В.И.Ягудина 1972г) всех опухолей пищеварительной системы. При этом на злокачественные опухоли приходится примерно 70%, доброкачественные – 30%.

Цель исследования: сообщить о редкой патологии.

В диагностике опухолей тонкой кишки особое место занимает рентгенологический метод исследования. При контрастировании бариевой взвесью обнаруживается сама опухоль, ее размеры, уровень и размеры пораженного участка кишки. По данным Ю.Н.Соколова и В.Б.Антоновича доброкачественные опухоли локализуются равномерно с одинаковой частотой по всему желудочнокишечному тракту, при локализации в тонкой кишке чаще единичные, реже множественные. Могут быть с эндофитным ростом, исходящим из слизистой оболочки, подслизистого слоя. С экзофитным ростом, исходящим из мышечного и серозного слоев. Для доброкачественных опухолей характерен рост в виде одиночного узла, могут иметь широкое основание или быть «на ножке». Нередко экзофитные опухоли достигают больших размеров, нежели эндофитные.

Материалы и методы. Нами представлено наблюдение фибромы луковицы двенадцатиперстной кишки. Эти опухоли возникают в подслизистом слое из фибробластов и коллагеновой ткани, локализуются в начальном или конечном отделе кишечника.

Пациентка (Е. 1947г.р.) обратилась с жалобами на дискомфорт после приема пищи, отрыжку, потери веса не отмечала. Перешла на дробное питание малыми порциями. В анамнезе - холецистэктомия, свои жалобы связывала с перенесенной операцией.

При рентгенологическом исследовании желудка в луковице двенадцатиперстной кишки выявлен дефект наполнения овальной формы, размером 2,0×2,5 см., при этом бариевая взвесь дугообразно обтекала данное образование, имеющее ровные, четкие контуры, без дополнительных включений. Выход контраста в двенадцатиперстную кишку сохранен.

Пациентка направлена на эндоскопическое исследование с заключением «доброкачественная опухоль луковицы двенадцатиперстной кишки». При эндоскопическом исследовании выявлено подслизистое образование луковицы двенадцатиперстной кишки (фиброма). Биопсия: полиповидное разрастание с участками умеренной дисплазии в подслизистом слое, фиброзирование с лимфоидной инфильтрацией. От предложенного оперативного лечения пациентка отказалась.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ KI-67 ПРИ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ.

Югай Т.А.

Городской онкологический диспансер, г.Алматы

При раковой трансформации ткани эндометрия в структурных изменениях участвуют все элементы обмена клетки, что позволяет учесть все количественные и качественные сдвиги на молекулярном уровне. Одним из таких маркеров является антиген Ki-67, характеризующий активность или агрессивность пролиферативного процесса в раковой ткани.

Экспрессия антигена Ki-67 была определена в опухолях 131 больных раком тела матки: 119 эндометриоидных и 12 неэндометриоидных.

Индекс Ki-67 в неэндометриоидных опухолях тела матки

находился в интервале от 19% до 62%, среднее значение Ki-67 в неэндометриоидных опухолях тела матки составило $36,2 \pm 6,6\%$. В эндометриоидных аденокарциномах минимальное значение индекса Ki-67 равнялось 15%, а максимальное - 70%, составив в среднем $41,37 \pm 1,8\%$. При сравнении средних значений индекса Ki-67 в эндометриоидных и неэндометриоидных опухолях матки при помощи статистически значимых различий не обнаружено ($p > 0,05$). Не выявлено статистически достоверных различий в уровне индекса Ki-67 в железистых и железисто-плоскоклеточных раках тела матки ($40,9 \pm 1,7\%$ против $44 \pm 3,8\%$, $p > 0,05$).

Сравнение средних значений Ki-67 показывает, что наименьшее значение этого маркера наблюдается в неэндометриоидном раке - $36,25 \pm 6,6\%$ наибольшее - при железисто - плоскоклеточном $44 \pm 3,8\%$. Среднее значение Ki-67 для всех видов РЭ составил $40,7 \pm 3,8\%$. Таким образом, железисто-плоскоклеточная форма рака эндометрия отнесена в группу с неблагоприятным исходом.

Индекс пролиферации зависел от возраста больных раком эндометрия. У больных моложе 50 лет высокая пролиферативная активность Ki-67 имела место у 16,7%, в группе 51-60 лет отмечалась наиболее высокая частота пролиферативной активности Ki-67 - 67,3%, а у больных старше 60 лет показатель Ki-67 > 42% составил 44,9%.

Проллиферативная активность является ведущим фактором как в механизме злокачественной трансформации клеток, так и в биологическом поведении уже возникших опухолей. Ki-67 прямо коррелирует с возрастом больных, степенью гистологической злокачественности опухоли. Кроме того, пролиферативный индекс служит независимым прогностическим показателем 5-летней выживаемости пациентов.

РОЛЬ РАННЕГО ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ

Эшонов А.К., Джурарев Ф.М.

*Онкологический научный центр Узбекистана,
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент*

Цель: Улучшить непосредственные результаты хирургического лечения рака желудка.

Материалы и методы: Изучено значение раннего зондового питания после операции гастрэктомии (ГЭ) у 64 больных раком желудка III-IV стадии. Всем больным во время операции проведен назоеюнальный зонд с внутренним диаметром 5 мм через эзофагоеюноанастомоз и установлен на 30-35 см ниже Браунского анастомоза. Питание через назоеюнальный зонд начали на 3 сутки после. С 3 суток капельно вводились различные жидкие питательные смеси в объеме до 500 мл в течение 4-5 часов. На 4 сутки количество вводимой смеси доводили от 800 до 1000 мл, а начиная с 5 суток в среднем 1,5 литра. Данная процедура продолжалась до 8 суток после операции. Контрольную группу составили 78 больных после ГЭ, которым энтеральное питание проводилось с 7-8 суток после рентгенологического контроля состояния пищеводно-кишечного анастомоза. Непосредственные результаты энтерального зондового питания в обеих группах изучали по критериям:

- 1) По уровню белковой, липидной фракции и иммунного статуса в послеоперационном периоде.
- 2) По частоте гнойно-септических осложнений.
- 3) По сроку ранней активизации больных после ГЭ.

Результаты: В основной группе явления гипопроотеинемии, которые обычно снижаются, начиная с 2-3 суток, держались весь послеоперационный период стабильно на уровне 66-74 г/л. Холестерин на уровне 3,70-5,82 м. А в контрольной группе отмечалось угнетение общего белка гипопроотеинемии и гипохолестеринемии на уровне 60,2 - 65,2 г/л и 2,82 - 3,75 соответственно. Изучение восстановления иммунной системы в основной группе показало, что она происходит в

ближайшее время после операции и на 9-11 дней раньше, чем в контрольной группе. В основной группе с учетом общего состояния больных физическая активизация начата на 4 сутки, а в контрольной группе на 7-8 сутки, что отрицательно сказывается на общем состоянии пожилых больных с нарушением сердечно-сосудистой и легочной системы. Частота гнойно-септических осложнений в целом по основной группе встречалась у 7 (10,9%) больных, а в контрольной группе у 13 (16,6%) больных ($P < 0,05$).

Вывод: Раннее энтеральное питание после операции достоверно улучшает белковую и липидную фракции организма, восстанавливает иммунную систему, способствует ранней физической активности и уменьшает частоту гнойно-септических осложнений.

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДИФЕРИЛИН 11,25 МГ ПРИ РПЖ.

Шатковская О.В.

Городской онкологический диспансер город Алматы.

Рак предстательной железы (РПЖ) относится к наиболее часто выявляемым опухолям среди онкологических заболеваний у мужчин, диагностируется у пожилых пациентов, реже - у мужчин до 40 лет. В г. Алматы доля рака простаты в структуре заболеваемости мужского населения растет. В структуре онкологической заболеваемости на долю урологических локализаций приходится 9,4%, из них - 32% - рак предстательной железы (РПЖ) - 2009г.

Прирост абсолютного числа заболевших в 2003-2009 годах по РПЖ составил 104%.

На стадии генерализованного опухолевого процесса гормонотерапия является ведущим и эффективным вариантом лечения. При локализованном (II стадия) и местнораспространенном (III стадия) раке предстательной железы гормональная терапия также может применяться. Основной целью проведения неoadъювантной и адъювантной гормонотерапии является увеличение общей и безрецидивной выживаемости больных РПЖ, но в различных клинических ситуациях гормонотерапия решает различные задачи.

Одним из ключевых звеньев в гормональной терапии РПЖ являются агонисты ЛГРГ - трипторелин, гозерелин.

В Городском Онкологическом Диспансере (ГОД) г Алматы при лечении распространенного рака предстательной железы применяется представитель агонистов ЛГРГ - Диферилин 3,75 мг (трипторелин). Это синтетический декапептид, аналог природного гонадотропин-рилизинг-гормона. Механизм его действия основан на подавлении секреции гонадотропина и функции гонад.

В течение 2009 года на базе ГОД г.Алматы применялась новая - трехмесячная форма Диферилин 11,25 мг, препарат вводился 1 раз в 3 месяца, что позволяло снизить количество посещений пациентов врачом, при этом качество их жизни улучшилось, а течение самого заболевания оставалось под контролем специалистов.

Диферилин 11,25 мг употреблялся у 35 пациентов с распространенным раком предстательной железы (РПЖ). Все пациенты были с впервые установленными диагнозами. Возраст - от 65 до 75 лет. Каждый пациент получил по несколько инъекций. Наблюдение за больными проводилось в амбулаторном порядке.

В результате применения Диферилин 11,25 мг у пациентов с РПЖ к концу первого месяца наблюдения были достигнуты кастрационные значения уровней тестостерона и ПСА в крови, снижение костного болевого синдрома и дизурических явлений. Эти эффекты сохранялись в течение всего временного промежутка.

Клинически значимых побочных явлений за период наблюдения у больных, получавших Диферилин 11,25 мг, не

отмечалось.

В целом применение препарата было надежным и эффективным. У пациентов наблюдался стойкий кастрационный эффект на фоне хорошей переносимости терапии. Данная форма лекарственного средства была удобна как для больного, так и для врача.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕМОДАЛА (ТЕМОЗОЛОМИД) В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Жумадуллаев Б.М.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г.Алматы

Актуальность. В республике Казахстан ежегодно регистрируется до 50 первичных случаев заболевания опухолей головного мозга (ОГМ) у детей, что составляет 20-25% среди всех солидных новообразований. Злокачественные глиомы (ЗГ) – анапластическая астроцитома (АА) и мультиформная глиобластома (МГБ) составляют от 7 до 11% среди всех опухолей центральной нервной системы (ЦНС) у детей. Отмечается рост заболеваемости с опухолями ЦНС у детей. Так в 2000 году заболеваемость с ОГМ составила 18,2%, в 2009 году – 20,2%.

Общепринятым лечением ЗГ является максимальное удаление опухоли, проведение постоперационной лучевой терапии (ЛТ) и применение различных схем химиотерапии.

Неудовлетворительные результаты и высокая токсичность применяемой химиотерапии явились причиной создания нового препарата с улучшенной переносимостью и простотой применения, который может быть использован в комбинации с другими препаратами или с ЛТ. Темодал – новое алкилирующее цитотоксическое соединение группы имидазотетразинов, проявляет высокую противоопухолевую активность *in vitro* и *in vivo* в отношении АА и МГБ [1-7]. В клинических исследованиях он показал 100% биодоступность при пероральном применении и хорошую проникающую способность через гематоэнцефалический барьер в ЦНС [2,3,8,9].

В мультицентровых исследованиях у взрослых пациентов с рецидивирующими глиомами была продемонстрирована эффективность темодала. У пациентов с рецидивом АА объективный ответ отмечался в 35% случаев. Годичная выживаемость составила 56%. В рандомизированном исследовании у больных с МГБ при сравнении темодала и прокарбазина, темодал по всем показателям оказался более эффективным. Полученные результаты свидетельствуют о несомненной активности темодала по отношению к ЗГ [10, 11, 12]. В последние годы наиболее хорошо зарекомендовала себя схема лечения, сочетающая лучевую терапию с применением темодала. Эффективность данной схемы была доказана в ряде исследований. По данным С.Сурго с соавт. применение темодала у взрослых больных после нерадикальных операций по поводу остаточной опухоли или рецидива глиом высокой степени злокачественности в сочетании с лучевой терапией, оказалось более чем в 3 раза эффективнее по сравнению с монотерапией темодалом [13,14, 15].

О.Г.Желудкова с соавт. демонстрируют эффективность темодала в лечении детей с АА и МГБ и при прогрессировании заболевания после предшествующего лечения [16].

Цель: изучение эффективности Темодала в лечении злокачественных глиом головного мозга у детей.

Объект и методы исследования: в отделении детской онкологии Казахского НИИ онкологии и радиологии с 2005 по 2009 гг. в исследование были включены 31 детей с ЗГТМ в возрасте от 3 до 17 лет, первым этапом, которым, проведены хирургическое лечение в отделении нейрохирургии №7 ГКБ г.Алматы и ННЦ нейрохирургии г.Астана. Характеристика пациентов представлена в табл. 1.

Объем хирургических вмешательств- 8 больным произ-

Таблица 1. Характеристика больных

Характеристика больных (n=31)	Число больных
Возраст, годы:	
разброс	3–17
медиана	8,9
Гистологический вид опухоли:	
анапластическая астроцитома	20 (64,5%)
мультиформная глиобластома	11 (35,5%)
Пол:	
мальчики	18 (58,1%)
девочки	13 (41,9%)
Объем хирургического лечения:	
«тотальное»	8
субтотальное	19
Биопсия опухоли	4

ведено «тотальное», 19 пациентам субтотальное удаление опухоли и 4 больным – биопсия опухоли. Диагноз у всех подтвержден морфологический. Гистологическая структура опухоли: анапластическая астроцитома – 20, глиобластома – 11 больных.

До начала терапии качества жизни больных по шкале Карновского от 40 до 60%.

Перед началом лечения и после каждого этапа терапии, а так же после завершения лечения в сроки 6, 12 и 18 мес. проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с контрастным усилением. Исследование показателей периферической крови проводилось еженедельно и в динамике после каждого курса химиотерапии. При оценке ответа на терапию использовали стандартные критерии: полный ответ (CR) – полное отсутствие опухоли, частичный ответ (PR) – уменьшение размера опухоли более 50%, стабилизация процесса (SD) – уменьшение размера опухоли менее 50%, прогрессирование процесса (PD) – увеличение размеров опухоли более 25% или появление новых очагов. Перед началом лечения и после каждого этапа терапии выполнялись клинический, неврологический и офтальмологический осмотры.

Лечение: Операция → ЛТ + ХТ (темозоломид + ломустин = 1 цикл) → 6 циклов ПХТ (темозоломид + ломустин). ЛТ проводился на линейном ускорителе, на 14-21 дни после операции, до СД= 50- 55 Гр., РД= 1,8 Гр. Одновременно с ЛТ в первую неделю облучения проводился цикл ХТ: темозоломид- 150 мг/м² - 1-5 дни; Ломустин – 120 мг/м² - 1 день + гормональная терапия. В дальнейшем 6 циклов ХТ по выше указанной схеме с интервалами в 6 нед. + сопроводительная терапия.

Результаты: 26 больным проведены и завершены все этапы терапии. В процессе и после завершения химиолучевого этапа терапии у 29 (93,5%) больных значительно купированы патологические неврологические симптомы, отмечены улучшение качества жизни: по шкале Карновского от 50-100%. У 2 (6,5%) пациентов с МГБ в процессе ХЛЛ отмечены ухудшение состояния и были исключены из исследования. Общие токсические проявления: головная боль, общая слабость, кратковременная гипертермия, а так же тошнота, рвота отмечена у всех пациентов, в основном II-III ст., и на фоне сопроводительной терапии были легко купируемые.

Гематологическая токсичность: лейкопения II-III ст. наблюдалась у 12 (38,7%) больных, тромбоцитопения II степени – у 8 (25,8%) пациентов, в основном после первого этапа терапии. Показатели периферической крови к началу цикловой ХТ нормализовались. Признаков органной и кумулятивной токсичности не наблюдалось.

По данным контрольного МРТ головного мозга с контрастным усилением, после ХЛЛ у 3 (10,3%) больных отмечены увеличение размеров опухоли, а у 26 детей (89,6%) достигнуто объективный ответ: CR- 7 (24,1%), PR- 14 (48,3%) SD- 5 (17,3%). В процессе цикловой ХТ 3 больных из-за прогрессирования заболевания переведены на симптоматическую терапию. После завершения протокола лечения по данным

контрольного МРТ головного мозга с контрастным усилением у 7 (26,9%) пациентов достигнута – CR, PR- у 9 (34,6%) SD – у 6 (23,1%) и у 4 (15,4%) больных – CR. Одногодичная выживаемость составила $83,9 \pm 6,6\%$, безрецидивная – $71 \pm 8,3\%$. 3-летняя выживаемость составила $57,7 \pm 9,9\%$, безрецидивная – $46,2 \pm 9,9\%$. 5-летняя выживаемость – $42,3 \pm 9,9\%$, безрецидивная – $34,6 \pm 9,5\%$.

Выводы: Применение темодала и ломустина на фоне и после ЛТ в лечении ЗГГМ у детей показало удовлетворительную эффективность без выраженных токсических симптомов и достигнуто улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения.

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.

Онгарбаев Б. Т.

КазНИИОиР, отделение онкоурологии

Рак мочевого пузыря является достаточно частой патологией: среди злокачественных заболеваний органов мочеполовой системы после опухолей почек находится на втором месте. Его встречаемость составляет 3,8 на 100 тыс населения нашей страны. На сегодняшний день, стандартом лечения инвазивного рака мочевого пузыря, признанного во всем мире, является радикальная цистэктомия.

Целью нашего исследования явилось определение тактики оперативного лечения при выявлении инвазивной формы рака мочевого пузыря

Материал и методы. С 2006 по 2009 годы и первое полугодие 2010 г в отделении онкоурологии КазНИИОиР находилось на лечении 560 больных раком мочевого пузыря, из них 121 больной прооперирован по поводу инвазивного рака мочевого пузыря: 29 больным проведена резекция мочевого пузыря, 125 больным – радикальная цистпростатэктомия. Характеристика больных представлена в таблице 1.

Средний возраст больных, которым произведена резекция мочевого пузыря составил лет, пациентов с цистэктомией – 60 лет.

В зависимости от местного распространения опухоли больные распределены следующим образом. У пациентов с резекцией мочевого пузыря – у 24 пациентов заболевание было ограничено стенкой мочевого пузыря (T2a-b), у 4 имела микроинвазия в перивезикальную клетчатку, у 1 больного опухоль распространялась на перивезикальную клетчатку. Для пациентов с радикальной цистэктомией у 61 больных отмечено прорастание мышечной оболочки, у 26 – прорастание в перивезикальную клетчатку и у 5 – опухоль распространялась на предстательную железу.

Во всех случаях гистологически был верифицирован переходно-клеточная рак.

Обращает на себя внимание уменьшение количества больных, которым проведена резекция мочевого пузыря (14 больных в 2006 году и 3 больных в 2009 году), и наоборот возрастание числа больных, которым произведена радикальная цистэктомия (в 2005 – 3, в 2006 году – 11, в 2009 – 33).

Больные, которым произведена резекция мочевого пузыря, были первичными, т.е. ранее специализированное лечение не получали. У% больных которым проведена радикальная цистэктомия, госпитализированы по поводу рецидива или прогрессирования заболевания на фоне ранее проводимого лечения.

Всем больным после резекции мочевого пузыря назначалась комбинированная (дистанционная лучевая) и/или комплексная терапия (системная полихимиотерапия – ПХТ по схеме гемзар-цисплатин).

Больным после радикальной цистэктомии, у которых опухоль ограничена мышечной стенкой (T2) и высокодифференцированными опухолями -G1 в после операционном периоде лечение не назначалось, всем остальным пациентам (T $\geq$ 2, G2-4, N+) назначались курсы ПХТ.

Результаты. Больные, которым мы провели резекцию мочевого пузыря, это люди пожилые, с массой сопутствующей патологией со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, анемией тяжелой степени, которым проведение оперативного лечения в объеме радикальной цистэктомии было сопряжено с высоким риском. У всех этих пациентов опухоль располагалась на подвижных

Таблица-1 Характеристика больных

Показатель	Резекция мочевого пузыря (по годам)					Радикальная цистэктомия (по годам)				
	2006	2007	2008	2009	Всего	2006	2007	2008	2009	Всего
Количество больных	14	9	3	3	29	11	15	33	33	92
Средний возраст, лет	62	68	75	72	69,2	59	64	65	64	63
Стадия										
T2a	0	2			5	2	2	4	3	11
T2b	10	6	1	2	19	8	5	19	18	50
T3a	3	6	2	1	12	0	5	5	7	17
T3b		1			1	1	1	3	4	9
T4a	1				1	1	2	2	1	5
Степень дифференцировки опухоли										
G1										
G2	7	5		1	13	3	2	3	6	14
G3-4	5	2	3	2	12	7	10	21	22	60
	2	2			4	1	3	9	5	18
Первичные пациенты	14	9	3	3	29	5	7	21	23	56
В анамнезе										
1. резекция мочевого пузыря						4	5	4	3	16
2. ТУР+в/пузырная ИТ*/ХТ**							1	5	2	8
3. Комбинированное лечение (резекция+ДЛТ***, ХТ)						2	2	3	5	12

ИТ* - иммунотерапия; ХТ** - химиотерапия; ДЛТ*** - дистанционная лучевая терапия

стенках, не превышала 5см в диаметре и была ограничена мышечной стенкой мочевого пузыря. Также этим пациентам проводилась регионарная лимфодиссекция с односторонней стороны с диагностической целью. В 8 случаях опухоль закрывала устье мочеточника с нарушением эвакуаторной функции почки и была произведена резекция с уретероцистостомией. Все пациенты в послеоперационном периоде находились под наблюдением. На фоне проведенного лечения у 5 больных выявлен рецидив заболевания и 2 больных умерли от прогрессирования процесса.

В послеоперационном периоде у пациентов после радикальной цистэктомии по различным причинам умерло 12 человек, из них в раннем послеоперационном периоде 3 больных. Анализ летальности в двух случаях выявил разлитой перитонит вследствие неостомоза, в одном – развитие тромбоза легочной артерии.

Выводы. Таким образом, при инвазивном раке мочевого пузыря на сегодняшний день стандартом лечения является проведение радикальной цистэктомии.

THE BIOLOGICAL CHARACTERISATION OF EARLY BREAST CANCER

Gábor CSERNI, MD, PhD, DSc

Department of Pathology, Bács-Kiskun County Teaching Hospital

Breast cancer is a heterogeneous disease that can be characterized according to several criteria. Of the multiple ways of classifying the disease, the best options also take into consideration the risk of relapse and/or the options of treatment.

1. Histological grade is a composite parameter which reflects the aggressivity of the tumor. However, grade 2 carcinomas seem to encompass a mixture of more and less aggressive cancers, therefore several initiatives have been made to separate grade 2 tumors into biologically significant subsets.

2. Although the assessment of proliferation is part of grading breast cancers, proliferation is also a marker of prognosis on its own. The use of Ki-67 antibodies on paraffin embedded breast cancer specimens is an attractive and seemingly easy way of quantifying proliferation, and tumors with a high proliferative activity generally have worse outcome. However, there are a number of issues requiring standardization before the Ki-67 could uniformly be used as a prognostic or predictive factor (highly proliferating tumors reacting better to chemotherapy).

3. A factor of obvious relevance is the estrogen receptor (ER) status of the tumor, which is often assessed in parallel with its progesterone receptor (PR) status. Good quality immunohistochemistry is required for this, and care should be taken to avoid false-positive and false-negative results. The ASCO 2010 guidelines stress on this later issue and have accepted 1% as the lowest rate of nuclear staining for ER positivity.

4. HER-2 is both a prognostic and a predictive marker of breast cancer. Its overexpression is assessed by immunohistochemistry, whereas gene amplification is generally assessed with different

techniques of in situ hybridisation, including fluorescent, chromogenic and one based on the conversion of ionic silver to metallic silver. Although there is good concordance between these assays, the match is not perfect. Dual immunostaining may offer some advantage over the use of a single anti-HER-2 antibody, and some results on such dual staining will be presented along with a comparison of chromogenic in situ hybridization with immunostaining.

5. Urokinase plasminogen activator (uPA) and its inhibitor (PAI-1) seem to be differentially expressed in aggressive breast cancers (high levels) versus less aggressive tumors (low levels). However, testing for these proteins is not readily available, therefore they are not widely recommended despite high level of evidence of their prognostic relevance.

6. Gene expression profiling is a novel way of characterizing breast carcinomas. These tests are still under investigation, and the relevant studies already initiated are still in their recruitment phase. Nevertheless, the 21 gene assay (Oncotype Dx) is commercially available and rather widely used in North America. Its use is restricted to ER-positive carcinomas, and its recurrence score takes into account many of the previously mentioned factors (ER-related genes, HER-2, proliferation).

7. Despite our increasing knowledge of cancer biology, the better outcome of screen detected breast carcinomas (compared to symptomatic carcinomas) can only partially be explained by the differences in stage and known (easily testable) biological markers.

Whatever the method of classification used, there will be outliers. The majority of the cases can currently be classified according to treatment tailoring needs on the basis of anatomical factors (size, nodal status) and biological factors (grade, ER, PR, HER-2), and some further adjustment can be made on the basis of proliferation or other methods under intensive investigation such as uPA-PAI-1 or gene expression profiling.